



Nuansa
Fajar
Cemerlang

DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KECEMASAN IBU HAMIL DALAM MENGHADAPI PERSALINAN

Warda Anil Masyayih
Eny Siswati



**DUKUNGAN KELUARGA
TERHADAP KECEMASAN IBU HAMIL
DALAM MENGHADAPI PERSALINAN**

Bdn. Warda Anil Masyayih, SST.,M.Kes.

Bdn. Eny Siswati SST.,M.Si.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Dukungan Keluarga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan

Penulis: Bdn. Warda Anil Masyayih SST.,M.Kes.
Bdn. Eny Siswati SST.,M.Si.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7097-87-3

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Dukungan keluarga terhadap kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan / Bdn. Warda Anil Masyayih, S.S.T., M.Kes., Bdn. Eny Siswati, S.S.T., M.Si.
EDISI	Cetakan pertama, Februari 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.
DESKRIPSI FISIK	vi, 82 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7097-87-3
SUBJEK	Kehamilan -- Persalinan
KLASIFIKASI	618.24 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1185367

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang Mahakuasa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga buku **Dukungan Keluarga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan** tahun 2024 dengan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga buku yang sudah dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan, yaitu orang tua kami, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku yang berjudul **Dukungan Keluarga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan** ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana ibu hamil menghadapi kecemasan.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya Dukungan keluarga bagi ibu hamil karena dapat memberikan rasa nyaman dan aman, serta mengurangi rasa cemas dan juga bagaimana materi yang disajikan yang relevan dengan banyak kejadian yang di alami oleh masyarakat.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Dukungan Keluarga Terhadap Kecemasan Ibu Hamil Dalam Menghadapi Persalinan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Desember, 2024

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	v

Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Dukungan Keluarga.....	5
A. Pengertian Dukungan Keluarga	5
B. Peran Keluarga.....	7
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga.....	8
D. Manfaat Dukungan Keluarga	11
Bab 3 Kecemasan.....	12
A. Pengertian Kecemasan	12
B. Gejala-Gejala Kecemasan.....	13
C. Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan	15
D. Jenis-Jenis Kecemasan	18
E. Gangguan Kecemasan	20
F. Dampak Kecemasan.....	21
Bab 4 Kehamilan.....	25
A. Pengertian Kehamilan	25
B. Tanda dan Gejala Kehamilan	25
C. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Kehamilan	32
D. Tanda-Tanda Dini Bahaya/Komplikasi Ibu dan Janin.....	38
Bab 5 Persalinan	41
A. Pengertian Persalinan.....	41
B. Etiologi.....	42
C. Tanda Persalinan.....	43
D. Tahapan Persalinan.....	45

E. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan.....	48
F. Kebutuhan Dasar Selama Persalinan	54
G. Persalinan Kala I.....	57
H. Persalinan Kala II	63
I. Persalinan Kala III	66
J. Persalinan Kala IV	69
Bab 6 Penutup	71
 Daftar Pustaka	 73
Glosarium	76
Profil Penulis	80

Bab 1

Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses yang alamiah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan normal adalah bersifat fisiologis, bukan patologis. Oleh karenanya, asuhan yang di berikan pun adalah asuhan yang meminimalkan intervensi. Kehamilan merupakan pengalaman yang sangat bermakna bagi perempuan, keluarga dan masyarakat. Perilaku ibu selama masa kehamilannya akan mempengaruhi kehamilannya, perilaku ibu dalam mencari penolong persalinan akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin yang dilahirkan. Tenaga medis harus mempertahankan kesehatan ibu dan janin serta mencegah komplikasi pada saat kehamilan dan persalinan sebagai suatu kesatuan yang utuh (Taufan, 2014).

Kehamilan adalah kondisi yang menimbulkan perubahan fisik maupun psikososial seorang wanita karena pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi dan janinnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kehamilan, dari dalam maupun dari luar yang dapat menimbulkan masalah, terutama bagi yang pertama kali hamil. Perubahan yang terjadi pada kehamilan akan berdampak pada aspek psikologi kehamilan. Upaya pemeliharaan kesehatan kehamilan tidak semata-mata di tujuhan kepada aspek fisik saja, tetapi aspek psikososial jugaperlu diperhatikan agar kehamilan dan persalinan berjalan lancar (Susanti, 2008).

Kehamilan merupakan suatu krisis maturitas yang dapat menimbulkan stres, untuk menjadi seorang ibu, seorang remaja harus beradaptasi dari kebiasaan dirawat ibu menjadi seorang ibu yang melakukan perawatan. Seorang dewasa harus mengubah kehidupan rutin menjadi suatu kehidupan yang tidak dapat diprediksi karena merawat bayi.

Kehamilan dan persalinan adalah suatu krisis maturitas yang dapat menimbulkan kecemasan atau bahkan stres, tetapi berharga karena wanita tersebut menyiapkan diri untuk memberi perawatan dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Seiring persiapan menghadapi peran baru, wanita mengubah konsep dirinya agar siap menjadi orang tua. Pertumbuhan ini membutuhkan penguasaan tugas-tugas tertentu, menerima kehamilan, mengidentifikasi peran ibu, mengatur hubungan dengan pasangannya, membangun hubungan dengan anak yang belum lahir, dan mempersiapkan diri menghadapi persalinan.

Ada beberapa negara berkembang di dunia yang berisiko tinggi terjadinya kecemasan sedang pada ibu hamil diantaranya negara Uganda ada sebanyak 18,2% ibu hamil mengalami kecemasan, di Nigeria sebanyak 12,5%, di Zimbabwe sebanyak 19%, dan di Afrika Selatan 41%. Sedangkan di benua Eropa ada sebanyak 81% wanita hamil di United Kingdom pernah mengalami gangguan kecemasan tingkat sedang pada kehamilannya. Sedangkan di Perancis ada sebanyak 7,9% ibu primigravida mengalami kecemasan sedang selama hamil (Herawati, Fitri, dan Paulina, 2021). Di Indonesia sendiri, terdapat 373.000.000 orang ibu hamil. Dan sebanyak 107.000 atau 28,7% diantaranya mengalami kecemasan yang terjadi pada ibu hamil trimester III menjelang proses persalinan (Siregar et al., 2021). Data profil kesehatan RI tahun 2020

menunjukkan terdapat 5.256.483 ibu hamil yang tercatat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Lebih dari setengah atau sebesar 54% ibu hamil mengalami perubahan psikologis berupa kecemasan selama kehamilan (Rustikayanti, Kartika, dan Herawati, 2016). Perubahan psikologis yang sering terjadi pada ibu hamil di usia kehamilan trimester I biasanya akan merasakan kekecewaan, penolakan, kecemasan, hingga rasa sedih. Sementara pada ibu hamil trimester II keadaan psikologis ibu akan tampak lebih tenang dan mulai mampu beradaptasi dengan kondisi yang dimilikinya. Sedangkan pada ibu hamil trimester III perubahan psikologis ibu akan lebih kompleks dibandingkan trimester sebelumnya akibat kondisi kehamilan yang sudah semakin membesar. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan tersebut, perubahan psikologis yang paling dominan dirasakan ibu hamil adalah rasa cemas yang akan terus dirasakan hingga masa persalinan (Elvina, ZA, dan Rosdiana, 2018).

Salah satu masalah gangguan emosional yang sering ditemui di masyarakat dan menimbulkan dampak psikologis cukup serius adalah ansietas/kecemasan. kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik, dialami secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal.

Kecemasan merupakan suatu respon yang diperlukan untuk hidup, namun bila tingkat cemas ini berat akan mengganggu kehidupan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kecemasan dapat disebabkan oleh adanya perasaan takut tidak diterima dalam lingkungan tertentu, pengalaman traumatis akan perpisahan atau kehilangan, rasa frustrasi akibat kegagalan dalam mencapai tujuan dan ancaman terhadap

integritas diri maupun konsep diri (Suliswati, 2005). Salah satu contoh kecemasan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah cemas saat menghadapi kejadian traumatik misalkan kecemasan menghadapi persalinan.

Kecemasan selama kehamilan dalam proses persalinan yang tidak dapat diatasi ibu menimbulkan ketegangan, menghalangi relaksasi tubuh, menyebabkan kelelahan atau bahkan mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan. Kondisi tersebut yang mengakibatkan otot tubuh menegang, terutama otot-otot yang berada di jalan rahim ikut menjadi kaku dan keras sehingga sulit mengembang. Tidak hanya itu, emosi yang tidak stabil dapat membuat rasa sakit meningkat. Menjelang persalinan, ibu hamil membutuhkan ketenangan agar proses persalinan menjadi lancar tanpa hambatan. Semakin ibu tenang menghadapi persalinan maka persalinan akan berjalan semakin lancar.

Dukungan sosial mempengaruhi kesehatan dengan cara melindungi individu dari efek negatif stress. Perlindungan ini akan efektif hanya ketika individu menghadapi stressor yang berat. Dukungan keluarga terutama dukungan yang didapatkan dari suami akan menimbulkan ketenangan batin dan perasaan senang dalam diri istri. Keluarga mempunyai fungsi dasar berupa fungsi afektif, yaitu fungsi internal keluarga untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, saling mengasuh dan memberikan cinta kasih, serta saling menerima dan mendukung. Kualitas dan kuantitas dukungan keluarga dinilai dari tiga parameter yaitu, dukungan materi, informasi, dan psikologis. Jadi sangatlah jelas jika dukungan keluarga yang diberikan kepada ibu selama kehamilan hingga menjelang persalinan akan membentuk coping efektif yang dapat mengeliminasi masalah psikologis (kecemasan) ibu.

Bab 2

Dukungan Keluarga

A. Pengertian Dukungan Keluarga

Keluarga adalah ibu, bapak, anak-anaknya, dan satu kekerabatan yang sangat mendasar di lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan suatu institusi kecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya yang didasari dari sebuah ikatan hidup serta didasarkan karena terjadi perkawinan, atau juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dukungan keluarga adalah sebagai suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosial, dukungan keluarga merupakan bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk barang, jasa, informasi, dan nasehat, sehingga membuat penerima dukungan akan merasa disayang, dihargai dan tentram (Saputri dan Sujarwo, 2017).

Dukungan keluarga terutama dukungan ayah dan ibu kandung maupun mertua sangat mempengaruhi kehamilan karena keluarga sering berkunjung dan juga memberi berdoa untuk keselamatan ibu dan bayi, walaupun ayah dan ibu kandung maupun mertua berada di daerah lain, dukungan mereka sangat di dambakan walaupun melalui telephone, surat ataupun doa dari jauh. Menurut (Zuhrotunida dan Yudiharto, 2017), bentuk dukungan keluarga dapat berupa:

1. Dukungan emosional

Dukungan yang diberikan berupa rasa empati dan perhatian kepada individu, sehingga membuatnya merasa lebih baik, mendapatkan kembali keyakinannya, merasa dimiliki dan dicintai oleh orang lain. Menurut Nugroho, dukungan emosional merupakan suatu bentuk dukungan berupa rasa aman, cinta kasih, memberi semangat, mengurangi putus asa dan rendah diri sebagai akibat dari ketidakmampuan fisik. Dukungan emosional dalam keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga.

2. Dukungan penilaian

Penilaian mengacu pada kemampuan untuk menafsirkan lingkungan dan situasi diri dengan benar dan mengadaptasi suatu perilaku dan keputusan diri secara tepat. Keluarga sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik atas pencapaian anggota keluarga dengan cara memberikan support, pengakuan, penghargaan, dan perhatian sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri pada individu.

3. Dukungan instrumental
Keluarga menjadi sumber pemberi pertolongan secara nyata. Misalnya bantuan langsung dari orang yang diandalkan seperti memberikan materi, tenaga, dan sarana. Manfaat dari diberikannya dukungan ini yaitu individu merasa mendapat perhatian atau kepedulian dari lingkungan keluarga.
4. Dukungan informasi
Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, nasihat, dan bimbingan kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Manfaat dari dukungan ini dapat menekan munculnya stressor karena informasi tertentu dapat memberikan pengaruh sugesti pada individu.

B. Peran Keluarga

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satuan hidup, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ikatan keluarga tersebut mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi dan anggota keluarga, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewajiban. Selain itu keluarga menyediakan situasi belajar dilihat pada saat masih bayi dan anak-anak sangat bergantung kepada orang tuanya, baik keadaan jasmaninya maupun kemampuan intelektual, sosial dan moral. Sejak masih kecil seorang anak selalu meniru apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya dimulai dari hal-hal yang dasar semisal belajar berjalan, berbicara, merawat diri dan masih banyak hal yang dipelajari anak dari orang tua.

Kesadaran dan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara kontinu perlu dikembangkan kepada setiap

orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak berdasar kebiasaan orang tua namun sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sebagian besar sifat anak diperoleh dari hasil mencontoh sifat orang tuanya ataupun anggota keluarga lainnya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Hampir semua ibu hamil menginginkan dekat dengan suami dan keluarganya. Ibu hamil selalu ingin ditemani pada saat pemeriksaan maupun saat persalinan tetapi berhubung suaminya bekerja maka pada saat suami bekerja ada sebagian yang memeriksa kehamilannya ditemani oleh keluarga seperti orang tua, mertua, maupun saudara. Dukungan keluarga sangat membantu dalam berbagai hal, karena dapat mengurangi perasaan was-was dan gelisah pada saat mendekati proses persalinan dan juga dapat memberikan perasaan nyaman dimana informasi yang belum diketahui sebelumnya dapat diketahui dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman seperti orangtua atau mertua yang sudah berpengalaman dapat memberikan informasi tentang kehamilan dan proses persalinan yang telah dilalui. Adapun dukungan keluarga yang lain yaitu menemani saat pemeriksaan, membantu tugas saat dirumah, memberikan nasehat, memberi semangat dan suami menghibur saat sedang cemas dan sedih.

Dukungan keluarga yang sangat dibutuhkan oleh wanita hamil anak pertama pada trimester ketiga untuk mengurangi kecemasan seperti dukungan emosional yaitu empati, rasa cinta, kasih sayang, dan kepercayaan yang

didalamnya terdapat pengertian dan keterbukaan. Ibu berharap selalu dekat dengan suami dan keluarga agar mereka membantu memberikan semangat, bantuan, dan memberikan dukungan sehingga perasaan ibu hamil lebih nyaman dan perasaan cemas tersebut lebih berkurang. (Saputri dan Sujarwo, 2017). Sebaliknya ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga akan panik karena takut untuk menghadapi persalinan dan tidak adanya keluarga untuk berbagi dan menjaganya (Dinopawe et al.,2021).

Menurut Purnawan (2008) dalam Rahayu (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah:

1. Faktor internal

- a. Tahap perkembangan

Artinya dukungan dapat ditentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan yang berbeda-beda.

- b. Pendidikan atau tingkat pengetahuan

Keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan terbentuk oleh variable intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya.

- c. Faktor emosi

Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap adanya dukungan dan cara melakukannya.

Seseorang yang mengalami respon stress dalam setiap perubahan hidupnya cenderung berespon terhadap berbagai tanda sakit, mungkin dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam kehidupannya. Seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit. Seorang individu yang tidak mampu melakukan koping secara emosional terhadap ancaman penyakit mungkin.

d. Spiritual Aspek

Spiritual dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup.

2. Faktor Eksternal

a. Praktik di keluarga

Cara bagaimana keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam melaksanakan kesehatannya. Misalnya, klien juga kemungkinan besar akan melakukan tindakan pencegahan jika keluarga melakukan hal yang sama.

b. Faktor sosio-ekonomi

Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakitnya. Variable psikososial mencakup: stabilitas perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan kerja. Seseorang biasanya akan mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok sosialnya, hal ini akan mempengaruhi keyakinan kesehatan dan cara

pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang biasanya ia akan lebih cepat tanggap terhadap gejala penyakit yang dirasakan. Sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan pada kesehatannya.

c. Latar belakang budaya

Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan individu, dalam memberikan dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan pribadi.

D. Manfaat Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga sangat membantu dalam berbagai hal, karena dapat mengurangi perasaan was-was dan gelisah pada saat mendekati proses persalinan dan juga dapat memberikan perasaan nyaman dimana informasi yang belum diketahui sebelumnya dapat diketahui dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman seperti orangtua atau mertua yang sudah berpengalaman dapat memberikan informasi tentang kehamilan dan proses persalinan yang telah di lalui. Sebaliknya ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga akan panik karena takut untuk menghadapi persalinan dan tidak adanya keluarga untuk berbagi dan menjaganya (Dinopawe et al.,2021).

Bab 3

Kecemasan

A. Pengertian Kecemasan

Pada dasarnya, kecemasan merupakan hal wajar yang pernah dialami oleh setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya (Sutardjo Wiramihardja, 2005:66).

Kecemasan adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang. Kecemasan bisa muncul sendiri atau bergabung dengan gejala-gejala lain dari berbagai gangguan emosi.

Menurut Kaplan, Sadock, dan Grebb (Fitri Fauziah & Julianti Widuri, 2007:73) kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup. Kecemasan adalah reaksi yang dapat dialami siapapun. Namun cemas yang berlebihan, apalagi yang sudah menjadi gangguan akan

menghambat fungsi seseorang dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis (Kholil Lur Rochman, 2010:104).

B. Gejala-Gejala Kecemasan

Kecemasan adalah suatu keadaan yang menggoncangkan karena adanya ancaman terhadap kesehatan. Individu-individu yang tergolong normal kadang kala mengalami kecemasan yang menampak, sehingga dapat disaksikan pada penampilan yang berupa gejala-gejala fisik maupun mental. Gejala tersebut lebih jelas pada individu yang mengalami gangguan mental. Lebih jelas lagi bagi individu yang mengidap penyakit mental yang parah.

Gejala-gejala yang bersifat fisik diantaranya adalah: jari tangan dingin, detak jantung makin cepat, berkeringat dingin, kepala pusing, nafsu makan berkurang, tidur tidak nyenyak, dada sesak. Gejala yang bersifat mental adalah ketakutan merasa akan ditimpa bahaya, tidak dapat memusatkan perhatian, tidak tenteram, ingin lari dari kenyataan.

Kecemasan juga memiliki karakteristik berupa munculnya perasaan takut dan kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Gejala-gejala kecemasan yang muncul dapat berbeda pada masing-masing orang. Kaplan, Sadock, & Grebb (Fitri Fauziah & Julianti Widury, 2007:74) menyebutkan bahwa takut dan cemas merupakan dua emosi yang berfungsi

sebagai tanda akan adanya suatu bahaya. Rasa takut muncul jika terdapat ancaman yang jelas atau nyata, berasal dari lingkungan, dan tidak menimbulkan konflik bagi individu. Sedangkan kecemasan muncul jika bahaya berasal dari dalam diri, tidak jelas, atau menyebabkan konflik bagi individu.

Kecemasan berasal dari perasaan tidak sadar yang berada didalam kepribadian sendiri, dan tidak berhubungan dengan objek yang nyata atau keadaan yang benar-benar ada. Kholil Lur Rochman, (2010:103) mengemukakan beberapa gejala-gejala dari kecemasan antara lain:

1. Ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hati, hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas.
2. Adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah dan sering dalam keadaan exited (heboh) yang memuncak, sangat irritable, akan tetapi sering juga dihindangi depresi.
3. Diikuti oleh bermacam-macam fantasi, delusi, ilusi, dan delusion of persecution (delusi yang dikejar-kejar).
4. Sering merasa mual dan muntah-muntah, badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemetar, dan seringkali menderita diare.
5. Muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis yang menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi.

Nevid Jeffrey S, Spencer A, & Greene Beverly (2005:164) mengklasifikasikan gejala-gejala kecemasan dalam tiga jenis gejala, diantaranya yaitu:

1. Gejala fisik dari kecemasan yaitu: kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, mudah marah atau tersinggung.
2. Gejala behavioral dari kecemasan yaitu: berperilaku menghindar, terguncang, melekat dan dependen.
3. Gejala kognitif dari kecemasan yaitu: khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi dimasa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan, sulit berkonsentrasi.

C. Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan sebagian besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup seseorang. Peristiwa-peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya serangan kecemasan. Menurut Savitri Ramaiah (2003:11) ada beberapa faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan, diantaranya yaitu:

1. Lingkungan Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berfikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja. Sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya.
2. Emosi yang ditekan Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini,

terutama jika dirinya menekan rasa marah atau frustrasi dalam jangka waktu yang sangat lama.

3. Sebab-sebab fisik Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan, semasa remaja dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan.

Zakiah Daradjat (Kholil Lur Rochman, 2010:167) mengemukakan beberapa penyebab dari kecemasan yaitu:

1. Rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam dirinya. Kecemasan ini lebih dekat dengan rasa takut, karena sumbernya terlihat jelas didalam pikiran.
2. Cemas karena merasa berdosa atau bersalah, karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Kecemasan ini sering pula menyertai gejala-gejala gangguan mental, yang kadang-kadang terlihat dalam bentuk yang umum.
3. Kecemasan yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Kecemasan ini disebabkan oleh hal yang tidak jelas dan tidak berhubungan dengan apapun yang terkadang disertai dengan perasaan takut yang mempengaruhi keseluruhan kepribadian penderitanya.

Kecemasan hadir karena adanya suatu emosi yang berlebihan. Selain itu, keduanya mampu hadir karena lingkungan yang menyertainya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun penyebabnya. Musfir Az-Zahrani (2005:511) menyebutkan faktor yang memepengaruhi adanya kecemasan yaitu:

1. Lingkungan keluarga

Keadaan rumah dengan kondisi yang penuh dengan pertengkaran atau penuh dengan kesalahpahaman serta adanya ketidakpedulian orangtua terhadap anak-anaknya, dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta kecemasan pada anak saat berada didalam rumah.

2. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan individu. Jika individu tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik, dan individu tersebut menimbulkan suatu perilaku yang buruk, maka akan menimbulkan adanya berbagai penilaian buruk dimata masyarakat. Sehingga dapat menyebabkan munculnya kecemasan.

Kecemasan timbul karena adanya ancaman atau bahaya yang tidak nyata dan sewaktu-waktu terjadi pada diri individu serta adanya penolakan dari masyarakat menyebabkan kecemasan berada di lingkungan yang baru dihadapi (Patotisuro Lumban Gaol, 2004: 24). Sedangkan Page (Elina Raharisti Rufaidah, 2009: 31) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah:

1. Faktor fisik

Kelemahan fisik dapat melemahkan kondisi mental individu sehingga memudahkan timbulnya kecemasan.

2. Trauma atau konflik

Munculnya gejala kecemasan sangat bergantung pada kondisi individu, dalam arti bahwa pengalaman-pengalaman emosional atau konflik mental yang terjadi pada individu akan memudahkan timbulnya gejala-gejala kecemasan.

3. Lingkungan awal yang tidak baik

Lingkungan adalah faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kecemasan individu, jika faktor tersebut kurang baik maka akan menghalangi pembentukan kepribadian sehingga muncul gejala-gejala kecemasan.

D. Jenis-Jenis Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu perubahan suasana hati, perubahan didalam dirinya sendiri yang timbul dari dalam tanpa adanya rangsangan dari luar. Mustamir Pedak (2009:30) membagi kecemasan menjadi tiga jenis kecemasan yaitu:

1. Kecemasan Rasional Merupakan suatu ketakutan akibat adanya objek yang memang mengancam, misalnya ketika menunggu hasil ujian. Ketakutan ini dianggap sebagai suatu unsur pokok normal dari mekanisme pertahanan dasarnya kita.
2. Kecemasan Irrasional Yang berarti bahwa mereka mengalami emosi ini dibawah keadaankeadaan spesifik yang biasanya tidak dipandang mengancam.
3. Kecemasan Fundamental Kecemasan fundamental merupakan suatu pertanyaan tentang siapa dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan kemanakah kelak hidupnya berlanjut. Kecemasan ini disebut sebagai kecemasan eksistensial yang mempunyai peran fundamental bagi kehidupan manusia.

Sedangkan Kartono Kartini (2006: 45) membagi kecemasan menjadi dua jenis kecemasan, yaitu:

1. Kecemasan Ringan Kecemasan ringan dibagi menjadi dua kategori yaitu ringan sebentar dan ringan lama. Kecemasan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan

kepribadian seseorang, karena kecemasan ini dapat menjadi suatu tantangan bagi seorang individu untuk mengatasinya. Kecemasan ringan yang muncul sebentar adalah suatu kecemasan yang wajar terjadi pada individu akibat situasi-situasi yang mengancam dan individu tersebut tidak dapat mengatasinya, sehingga timbul kecemasan. Kecemasan ini akan bermanfaat bagi individu untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi-situasi yang sama di kemudian hari. Kecemasan ringan yang lama adalah kecemasan yang dapat diatasi tetapi karena individu tersebut tidak segera mengatasi penyebab munculnya kecemasan, maka kecemasan tersebut akan mengendap lama dalam diri individu.

2. Kecemasan Berat Kecemasan berat adalah kecemasan yang terlalu berat dan berakar secara mendalam dalam diri seseorang. Apabila seseorang mengalami kecemasan semacam ini maka biasanya ia tidak dapat mengatasinya. Kecemasan ini mempunyai akibat menghambat atau merugikan perkembangan kepribadian seseorang. Kecemasan ini dibagi menjadi dua yaitu kecemasan berat yang sebentar dan lama. Kecemasan yang berat tetapi munculnya sebentar dapat menimbulkan traumatis pada individu jika menghadapi situasi yang sama dengan situasi penyebab munculnya kecemasan. Sedangkan kecemasan yang berat tetapi munculnya lama akan merusak kepribadian individu. Hal ini akan berlangsung terus menerus bertahun-tahun dan dapat merusak proses kognisi individu. Kecemasan yang berat dan lama akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti darah tinggi, tachycardia (percepatan darah), excited (heboh, gempar).

E. Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan merupakan suatu gangguan yang memiliki ciri kecemasan atau ketakutan yang tidak realistik, juga irrasional, dan tidak dapat secara intensif ditampilkan dalam cara-cara yang jelas. Fitri Fauziah & Julianty Widuri (2007:77) membagi gangguan kecemasan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Fobia Spesifik

Yaitu suatu ketakutan yang tidak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap obyek atau situasi yang spesifik.

2. Fobia Sosial

Merupakan suatu ketakutan yang tidak rasional dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Individu menghindari situasi dimana dirinya dievaluasi atau dikritik, yang membuatnya merasa terhina atau dipermalukan, dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau menampilkan perilaku lain yang memalukan.

3. Gangguan Panik

Gangguan panik memiliki karakteristik terjadinya serangan panik yang spontan dan tidak terduga. Beberapa simtom yang dapat muncul pada gangguan panik antara lain; sulit bernafas, jantung berdetak kencang, mual, rasa sakit didada, berkeringat dingin, dan gemetar. Hal lain yang penting dalam diagnosa gangguan panik adalah bahwa individu merasa setiap serangan panik merupakan pertanda datangnya kematian atau kecacatan.

Gangguan Cemas Menyeluruh (Generalized Anxiety Disorder)

4. Generalized Anxiety Disorder (GAD) adalah kekhawatiran yang berlebihan dan bersifat pervasif, disertai dengan berbagai simtom somatik, yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial atau pekerjaan pada penderita, atau menimbulkan stres yang nyata.

Sedangkan Sutardjo Wiramihardja (2005:71) membagi gangguan kecemasan yang terdiri dari:

1. Panic Disorder

Panic Disorder ditandai dengan munculnya satu atau dua serangan panik yang tidak diharapkan, yang tidak dipicu oleh hal-hal yang bagi orang lain bukan merupakan masalah luar biasa. Ada beberapa simtom yang menandakan kondisi panik tersebut, yaitu nafas yang pendek, palpilasi (mulut yang kering) atau justru kerongkongan tidak bisa menelan, ketakutan akan mati, atau bahkan takut gila.

2. Agrophobia

Yaitu suatu ketakutan berada dalam suatu tempat atau situasi dimana ia merasa bahwa ia tidak dapat atau sukar menjadi baik secara fisik maupun psikologis untuk melepaskan diri. Orang-orang yang memiliki agrophobia takut pada kerumunan dan tempat-tempat ramai.

F. Dampak Kecemasan

Rasa takut dan cemas dapat menetap bahkan meningkat meskipun situasi yang betul-betul mengancam tidak ada, dan ketika emosi-emosi ini tumbuh berlebihan dibandingkan dengan bahaya yang sesungguhnya, emosi ini menjadi tidak adaptif. Kecemasan yang berlebihan dapat mempunyai dampak yang merugikan pada pikiran serta

tubuh bahkan dapat menimbulkan penyakitpenyakit fisik (Cutler, 2004:304).

Yustinus Semiun (2006:321) membagi beberapa dampak dari kecemasan kedalam beberapa simtom, antara lain:

1. Simtom suasana hati

Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Orang yang mengalami kecemasan tidak bisa tidur, dan dengan demikian dapat menyebabkan sifat mudah marah.

2. Simtom kognitif

Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah-masalah real yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif, dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas.

3. Simtom motor

Orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan, misalnya jari-jari kaki mengetuk-ngetuk, dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Simtom motor merupakan gambaran rangsangan kognitif yang tinggi pada individu dan merupakan usaha untuk melindungi dirinya dari apa saja yang dirasanya mengancam.

Kecemasan akan dirasakan oleh semua orang, terutama jika ada tekanan perasaan ataupun tekanan jiwa. Menurut Savitri Ramaiah (2005:9) kecemasan biasanya dapat menyebabkan dua akibat, yaitu:

1. Kepanikan yang amat sangat dan karena itu gagal berfungsi secara normal atau menyesuaikan diri pada situasi.
2. Gagal mengetahui terlebih dahulu bahayanya dan mengambil tindakan pencegahan yang mencukupi.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah rasa takut atau khawatir pada situasi yang sangat mengancam karena adanya ketidakpastian dimasa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan tersebut ditandai dengan adanya beberapa gejala yang muncul seperti kegelisahan, ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi dimasa depan, merasa tidak tenteram, sulit untuk berkonsentrasi, dan merasa tidak mampu untuk mengatasi masalah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, kecemasan timbul karena individu melihat adanya bahaya yang mengancam dirinya, kecemasan juga terjadi karena individu merasa berdosa atau bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani.

Dari beberapa gejala, faktor, dan definisi diatas, kecemasan ini termasuk dalam jenis kecemasan rasional, karena kecemasan rasional merupakan suatu ketakutan akibat adanya objek yang memang mengancam. Adanya berbagai macam kecemasan yang dialami individu dapat menyebabkan adanya gangguan-gangguan kecemasan seperti gangguan kecemasan spesifik yaitu suatu ketakutan

yang tidak diinginkan karena kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik. Sehingga dapat menyebabkan adanya dampak dari kecemasan yang berupa simtom kognitif, yaitu kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah-masalah real yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif, dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas.

Bab 4

Kehamilan

A. Pengertian Kehamilan

Wanita hamil adalah wanita yang hamil sejak pembuahan sampai dengan lahirnya janin. Kehamilan adalah masa transisi artinya, periode antara kehidupan prenatal anak saat ini dalam kandungan dan kehidupan setelah anak lahir (Ratnawati, 2020). Kehamilan adalah penyatuan sperma dan sel telur dan berlanjut sampai implantasi. Dari pembuahan hingga kelahiran bayi, kehamilan normal terjadi dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan dalam kalender internasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah pertemuan sel telur dan sperma di dalam dan di luar rahim dan diakhiri dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir (Yulaikah, 2019).

B. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda dan gejala kehamilan menurut Retnaningtyas (2016) diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Tanda dan Gejala Kehamilan Tidak Pasti

- a. Amenorroe (tidak dapat haid)

Wanita hamil biasanya tidak dapat haid lagi, maka penting untuk mengetahui hari pertama haid

terakhir (HPHT) untuk menentukan lama kehamilan dan perkiraan kelahiran.

b. Morning sickness

Mual (nausea) terjadi pada bulan-bulan awal kehamilan, terkadang disertai muntah (vomiting), yang sering terjadi pada pagi hari dan dikenal dengan istilah morning sickness. Sampai batas tertentu, kondisi ini bersifat fisiologis. 50% wanita hamil mengalami mual dan muntah setelah 4-14 minggu pembuahan, hal ini karena meningkatnya level Hcg dan estrogen dalam darah. Bila terlampau sering dapat mengakibatkan gangguan kesehatan disebut hiperemesis gravidarum.

c. Mengidam (Menginginkan makanan tertentu)

Mengidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan akan tetapi akan menghilang dengan makin tuanya kehamilan.

d. Payudara menjadi tegang dan membesar (Mastodinia)

Sejak 3-4 minggu kehamilan payudara menjadi tegang dan membesar. Hal ini karena estrogen dan hormon progesteron merangsang duktuli dan alveoli di Payudara, Glandula Montgomeri nampak lebih jelas. Akibat stimulasi prolaktin dan hari perkiraan lahir, payudara mensekresi kolustrum biasanya setelah kehamilan lebih dari 16 minggu.

e. Sering buang air kecil

Frekuensi buang air kecil (tanpa tanda infeksi, nyeri) meningkat selama 8-14 minggu kehamilan. Ini terjadi karena:

- 1) Peningkatan volume darah
 - 2) Peningkatan aliran darah ke ginjal dan filtrasi glomerulus yang meningkatkan produksi urine
 - 3) Kandung kemih tertekan uterus yang membesar. Gejala ini hilang pada trimester kedua saat rahim yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada trimester ketiga, gejala ini muncul kembali saat janin mulai menyerang rongga panggul dan menekan kandung kemih.
- f. Quickening
- Ketika wanita hamil merasakan isyarat gerakan janin pertama kali disebut Quickening. Quickening terjadi pada wanita yang sangat menginginkan kehamilan dan merasa quickening sebelumnya. Pada multigravida terjadi sejak kehamilan 16 minggu, primigravida sejak kehamilan 18- 20 minggu.
- g. Perubahan suhu basal
- Sesudah ovulasi suhu tetap tinggi antara 37.2 - 37.0C adalah salah satu tanda adanya kehamilan. Kenaikan temperatur basal lebih dari 3 minggu biasanya merupakan tanda terjadinya kehamilan.
- h. Konstipasi
- Ini karena efek relaksasi hormon progesteron atau mungkin juga karena perubahan pola makan.
- i. Perubahan Berat badan
- Selama 2-3 bulan kehamilan, berat badan sering menurun akibat penurunan nafsu makan dan muntah. Pada bulan-bulan berikutnya, berat badan terus meningkat hingga stabil sebelum aterm.
- j. Perubahan pada mukosa vagina
- Selama kehamilan mukosa vagina tampak gelap kebiruan atau merah keunguan, keadaan ini disebut

tanda Chadwick. Gambaran ini merupakan presumtif namun perubahan serupa ini pun pada mukosa vagina dapat disebabkan oleh penyakit dari organ-organ panggul.

k. Perubahan Pada Kulit

- 1) Chloasma gravidarum: Setelah 16 minggu kehamilan, kulit di wajah menjadi gelap karena pengaruh sinar matahari.
- 2) Linea nigra: Warna puting susu dan linea alba menjadi gelap akibat stimulasi melanofor akibat peningkatan hormon perangsang melanosit.
- 3) Striae gravidarum: Benjolan di dada dan perut akibat rusaknya jaringan kolagen yang terlihat sebagai jaringan parut yang tidak beraturan. Hal ini diyakini disebabkan oleh aksi hormon adrenokortikosteroid dan terjadi pada tahap akhir kehamilan.
- 4) Spider telangiectasis: Kelainan kulit yang disebabkan oleh tingginya kadar estrogen yang bersirkulasi, yang juga dapat terjadi pada gagal hati.

l. Leukorea (keputihan)

Karena efek stimulasi hormon dan peningkatan aliran darah di panggul, terjadi peningkatan keluarnya cairan dari vagina pada awal kehamilan.

m. Perubahan pada Rahim

Ukuran, bentuk dan komposisi rahim berubah. Rahim menjadi lunak, bulat. Balotement teraba, tanda ini muncul setelah 16-20 minggu, setelah rongga rahim menghilang dan cairan ketuban cukup banyak. Balotemen merupakan tanda bahwa suatu benda terapung/mengapung dalam zat cair.

Diagnosis bandingnya adalah asites dengan kista ovarium, fibroid rahim, dan lain- lain.

2. Tanda dan Gejala Kemungkinan Hamil

- a. Hiperpigmentasi kulit
Terjadi selama kehamilan dari minggu ke-12, endapan pigmen tambahan yang dikenal sebagai kloasme gravidarum muncul di pipi, hidung, dan dahi. Areola dan leher ibu lebih gelap. Linea alba di garis tengah perut menjadi gelap (abu-abu). Hiperpigmentasi ini disebabkan oleh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit.
- b. Perubahan payudara/ keluar kolostrum
Pada minggu ke 8 hingga 12 kehamilan, peningkatan ukuran dan pigmentasi puting susu, areola, dan kelenjar Montgomery dapat terlihat. Sejak minggu ke- 16 kehamilan, kolostrum sudah bisa dikeluarkan.
- c. Pembesaran uterus dan perut
Terjadi pembesaran abdomen secara progresif dari kehamilan 7 sampai 28 minggu. Pada minggu 16-22, pertumbuhan terjadi secara cepat dimana uterus keluar panggul dan mengisi rongga abdomen.
- d. Perubahan organ pelvic
 - 1) Tanda Hegar
Tanda kehamilan yang menandakan pelunakan jaringan serviks, terutama pada isthmus serviks, yaitu bagian serviks yang menghubungkan vagina dengan rahim.

- 2) Tanda Chadwicks/ Jacquemier
Sejak minggu ke-8 kehamilan, perubahan warna menjadi biru-merah pada selaput lendir serviks, vagina, dan alat kelamin luar disebabkan oleh peningkatan aliran darah akibat efek estrogen.
- 3) Tanda Goodlell (melunaknya serviks)
Pada wanita tidak hamil seperti konsistensi hidung, pada wanita hamil seperti konsistensi bibir.
- 4) Tanda Piskacek
Pertumbuhan rahim tidak sama ke segala arah, namun terjadi pertumbuhan yang cepat di area plasenta, sehingga rahim tidak memiliki bentuk yang sama. Bentuk rahim yang tidak rata disebut tanda Piskacek.
- 5) Tanda kontraksi Braxton Hicks
Tingkat estrogen dan hormon progesteron, keseimbangan hormonal yang mempengaruhi rahim, sering berubah sehingga hormon progesteron menurun dan menyebabkan kontraksi rahim. Pada kondisi dimana rahim membesar tetapi tidak terjadi kehamilan, misalnya myoma uteri, tanda Braxton-Hicks tidak ditemukan. Sejak minggu ke-20 kehamilan, kontraksi sudah bisa dirasakan dengan meraba perut.
- 6) HCG positif
Metode khas untuk menentukan human chorionic gonadotropin (HCG) pada kehamilan muda adalah urin pagi pertama. Urine pertama bercampur dengan serum antibodi, bila tidak terjadi aglutinasi berarti reaksi positif hamil, bila terjadi aglutinasi berarti reaksi tidak hamil. Tes ini

sangat sederhana, murah dan dapat dibaca dalam 2 menit. Akurasi 97% 40 hari/6 minggu setelah hari pertama haid terakhir.

7) Teraba Balotemen

Pada usia kehamilan 16-20 minggu, dapat merasakan adanya benda yang memantul di dalam rahim (dalam tubuh janin) selama pemeriksaan bimanual.

3. Tanda dan Gejala Kehamilan Pasti

a. Denyut jantung janin positif

Denyut jantung janin diukur pada usia kehamilan 12 minggu dengan elektrokardiograf janin, pada usia kehamilan 18-20 minggu dengan stetoskop Laenec.

b. Teraba bagian janin

Pada palpasi abdominal, bagian janin dapat dipalpasi sejak kehamilan $\pm$ 24 minggu, letak dan presentasi dapat diketahui.

c. Teraba gerakan janin

Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan ibu pada kehamilan 18 minggu, sedangkan pada multigravida pada minggu ke 16. dengan palpasi gerakan janin dapat dirasakan pemeriksa pada umur kehamilan $\pm$ 20-22 minggu.

d. Dengan Rontgen

Tampak kerangka janin $\pm$ 15 minggu kehamilan, cara ini berbahaya karena dampak radiasi, cara ini dapat digunakan jika ada indikasi kematian janin.

e. Dengan Ultrasonografi

Dapat diketahui kantong janin sejak usia kehamilan 5 minggu, denyut jantung janin usia kehamilan 7 minggu., panjang janin (crown- rump) dan diameter

biparetalis, hingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan, dan selanjutnya dapat dipakai untuk menilai pertumbuhan janin. Dapat pula dipakai bila ada kecurigaan dalam kehamilan mola, blighted ovum, kematian janin intra uterin, anensefali, kehamilan ganda, hiDramnion, plasenta previa, tumor pelvis.

f. Fetoskopi.

Fetoskopi adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan pada janin dan plasenta sementara keduanya masih berada dalam kandungan. Pemeriksaan ini memberikan gambaran tentang si bayi dan plasenta abnormalitas dan masalah dapat dideteksi. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan endoskop melalui perut, alat yang mirip dengan yang digunakan dalam laparoskopi atau artroskopi. Prosedur ini mirip dengan amniositosis, tetapi fetoskopnya lebih besar. Jika dokter merekomendasikan pemantauan janin, diskusikan risiko, manfaat, dan bahaya dari prosedur ini. Tes ini hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis, resiko keguguran 3-4%, tidak semua Rumah Sakit bisa melakukan tes ini.

C. Perubahan Anatomi dan Fisiologis Kehamilan

Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada ibu hamil menurut Retnaningtyas (2016) meliputi sistem reproduksi, payudara, sistem endokrin, sistem imun dan sistem urinarius. Sebagian besar perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada wanita hamil terjadi segera setelah pembuahan dan berlanjut sepanjang kehamilan. Sebagian besar perubahan ini merupakan reaksi terhadap janin.

Tergantung pada usia kehamilan, wanita hamil mengalami perubahan anatomi dan fisiologis pada tubuhnya. Mulai dari trimester pertama hingga trimester ketiga. Perubahan anatomi tersebut meliputi perubahan pada sistem reproduksi, payudara, sistem endokrin, sistem imun dan sistem saluran kemih. Perubahan yang terjadi selama kehamilan kembali ke keadaan sebelum hamil setelah melahirkan dan menyusui.

1. Sistem reproduksi

a. Uterus

Pembesaran rahim disertai dengan peregangan dan penebalan sel otot, sedangkan produksi meosit baru sangat terbatas. Pada saat yang sama, jaringan ikat dan elastis menumpuk, terutama di lapisan otot luar. Kerja sama ini meningkatkan kekuatan dinding rahim. Pada bulan-bulan pertama area korpus akan menebal, tetapi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan akan menipis pada akhir kehamilan ketebalannya hanya sekitar 1,5 cm bahkan kurang.

b. Serviks

Serviks menjadi lunak (soft) yang disebut dengan tanda Goodell, banyak jaringan ikat yang mengandung kolagen, kelenjar servikal membesar dan mengeluarkan banyak cairan mukus karna pertambahan dan pelebaran pembuluh darah, warnanya menjadi livid yang disebut tanda Chadwick.

c. Ovarium

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus luteum yang dapat ditemukan di ovarium. Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6-7

minggu awal kehamilan. Dan setelah itu akan berperan sebagai penghasil progesteron dalam jumlah yang relatif minimal.

d. Vagina dan Vulva

Minggu ke-8 terjadi hipervaskularisasi sehingga vagina tampak merah dan kebiruan (tanda chatwick). pH vagina menjadi lebih asam. Dari 4 menjadi 6.5 menyebabkan rentan terhadap infeksi vagina. Mengalami deskuamasi/pelepasan elemen epitel pada sel-sel vagina akibat stimulasi estrogen membentuk rabas vagina disebut leukore (keputihan). Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi selama persalinan dengan produksi mukosa vagina yang tebal, jaringan ikat longgar, hipertropi otot polos dan pemanjangan vagina.

2. Payudara

Payudara (mamae) akan membesar dan tegang akibat hormon somatomotropin, estrogen dan hormon progesteron, akan tetapi belum mengeluarkan air susu ibu. Estrogen menimbulkan hipertropi sistem saluran, sedangkan hormon progesterone menambah sel-sel asinus pada mammae.

Somatomotropin mempengaruhi pertumbuhan sel-sel asinus pula dan menimbulkan perubahan dalam sel-sel sehingga terjadi pembuatan kasein, laktralbumin dan laktoglobulin. Dengan demikian mammae dipersiapkan untuk laktasi. Disamping itu dibawah pengaruh hormon progesteron dan somatomotropin terbentuk lemak sekitar alveolus-alveolus, sehingga mammae menjadi lebih besar. Papilla mammae akan membesar, lebih tegang dan tambah lebih hitam, seperti

seluruh areola mammae karena hiperpigmentasi. Hipertropi kelenjar sebacea (lemak) yang mungul diareola primer dan disebut tuberkel Montgomery. Glandula Montgomery tampak lebih jelas menonjol dipermukaan areola mammae.

Rasa penuh, peningkatan sensitivitas, rasa geli, dan rasa berat di payudara mulai timbul sejak minggu keenam gestasi. Perubahan payudara ini adalah tanda mungkin hamil. Sensivitas payudara bervariasi dari rasa geli ringan sampai nyeri tajam. Peningkatan suplai darah membuat pembuluh darah dibawah kulit berdilatasi. Pembuluh darah yang sebelumnya tidak terlihat, sekarang terlihat, seringkali tampak sebagai jalinan jaringan biru dibawah permukaan kulit. Kongsti vena di payudara lebih jelas terlihat pada primigravida. Striae dapat terlihat dibagian luar payudara.

3. Sistem endokrin

Perubahan penting dalam sistem endokrin, yang penting untuk kehamilan, pertumbuhan normal janin, dan pemulihan setelah melahirkan. Tes *human chorionic gonadotropin* (HCG) positif dan tingkat *human chorionic gonadotropin* (HCG) dengan cepat berlipat ganda setiap 48 jam hingga minggu keenam kehamilan. Perubahan hormon selama kehamilan terutama disebabkan oleh produksi estrogen dan hormon progesteron oleh plasenta dan hormon yang dikeluarkan oleh janin. Berikut ini adalah perubahan hormonal selama kehamilan (trimester I-III).

a. Estrogen

Produksi estrogen plasenta terus meningkat selama kehamilan dan sekitar 100 kali lebih tinggi pada akhir kehamilan dibandingkan selama kehamilan.

- b. Hormon progesteron
Produksi hormon progesteron bahkan lebih tinggi daripada estrogen. Pada akhir kehamilan, produksinya sekitar 250 mg/hari. Hormon progesteron mengurangi tonus otot polos dan diuresis. Hormon progesteron menumpuk lemak di jaringan subkutan perut, punggung, dan paha. Lemak berfungsi sebagai penyimpan energi baik selama kehamilan maupun selama menyusui.
- c. Human *chorionic gonadotropin* (HCG)
Hormon ini dapat dideteksi beberapa hari setelah pergantian dan merupakan dasar dari tes kehamilan. Sekresi maksimum terjadi sekitar 60 hari setelah pembuahan dan fungsi utamanya adalah untuk mengawetkan luteum.
- d. *Human placental lactogen* (HPL).
Hormone ini diproduksi terus naik dan pada saat aterm mencapai 2 gram/hari. Efeknya mirip dengan hormone pertumbuhan. Ia juga bersifat diabetogenik, sehingga kebutuhan insulin wanita hamil naik.
- e. *Pituitary Gonadotropin*
FSH dan LH berada dalam keadaan sangat rendah selama kehamilan karena ditekan oleh estrogen dan hormon progesterone plasenta.
- f. *Prolaktin*
Produksinya terus meningkat, sebagai akibat kenaikan sekresi estrogen, sekresi air susu sendiri dihambat oleh estrogen ditingkat target organ.
- g. *Growth hormone* (STH)
Produksinya sangat rendah karena mungkin ditekan *human placental lactogen* (HPL).

h. Titoksin

Kelenjar tiroid mengalami hipertropi dan produksi T4 meningkat. Tetapi T4 bebas relative tetap, karena thyroid binding globulin meninggi, sebagai akibat tingginya estrogen, dan juga merupakan akibat hyperplasia jaringan glandular dan peningkatan vaskularisasi. Tiroksin mengatur metabolisme.

i. Aldosteron, Renin dan angiotensin

Hormone ini naik, yang menyebabkan naiknya volume intravaskuler.

j. Insulin

Produksi insulin meningkat sebagai akibat estrogen, hormon progesterone dan *human placental lactogen* (HPL).

k. Parathormon

Hormone ini relative tidak dipengaruhi oleh kehamilan.

4. Sistem perkemihan

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kencing tertekan sehingga sering timbul kencing. Dan keadaan ini hilang dengan tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup banyak berubah, laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal meningkat pada kehamilan.

Bila satu organ membesar, maka organ lain akan mengalami tekanan, dan pada kehamilan tidak jarang terjadi gangguan berkemih pada saat kehamilan. Ibu akan merasa lebih sering ingin buang air kecil. Pada bulan pertama kehamilan kandung kemih tertekan oleh uterus yang mulai membesar.

Pada kehamilan normal fungsi ginjal cukup banyak berubah. Laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal meningkat pada awal kehamilan. Ginjal wanita harus mengakomodasi tuntutan metabolisme dan sirkulasi ibu yang meningkat dan juga mengekskresi produk sampah janin. Ginjal pada saat kehamilan sedikit bertambah besar, panjangnya bertambah 1-1,5 cm. Ginjal berfungsi paling efisien saat wanita berbaring pada posisi rekumbeng lateral dan paling tidak efisien pada saat posisi telentang. Saat wanita hamil berbaring telentang, berat uterus akan menekan vena ekava dan aorta, sehingga curah jantung menurun. Akibatnya tekanan darah ibu dan frekuensi jantung janin menurun, begitu juga dengan volume darah ginjal.

D. Tanda-Tanda Dini Bahaya/Komplikasi Ibu dan Janin

Tanda-tanda berbahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahaya yang mungkin terjadi selama kehamilan dan jika tidak dilaporkan atau dideteksi sejak dini, dapat menyebabkan kematian ibu dan janin. Semua tanda bahaya kehamilan dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan harus ditangani dan dikenali sejak dini (Retnaningtyas, 2016).

1. Tanda-tanda dini bahaya/komplikasi ibu dan janin masa kehamilan muda

a. Perdarahan Pervaginam

Perdarahan pada kehamilan muda atau usia kehamilan kurang dari 20 minggu, biasanya disebabkan oleh keguguran. Sekitar 10-12% kehamilan berakhir dengan keguguran yang biasanya (60-80%) disebabkan kelainan kromosom pada sperma atau sel telur. Molahidatidosa biasanya

disebabkan oleh penyebab dan penyebab yang sama yaitu gejala perdarahan pada kehamilan muda dan pembesaran rahim yang lebih besar dari normal. Pada awal kehamilan, perdarahan abnormal berwarna merah, berat atau nyeri. Perdarahan pada awal kehamilan dengan tes kehamilan yang tidak jelas, pembesaran rahim yang tidak sesuai (lebih kecil) untuk usia kehamilan, dan adanya massa di adneksa biasanya disebabkan oleh kehamilan ektopik.

b. Kehamilan ektopik terganggu

Kehamilan ektopik adalah kehamilan di mana implantasi terjadi di luar rongga rahim. Tuba falopi adalah tempat yang paling umum dari kehamilan ektopik (>90%). Gejala dan tandanya sangat bervariasi tergantung pada apakah kehamilan dihentikan atau tidak. Alat penting untuk digunakan dalam mendiagnosis kehamilan ektopik yang pecah adalah tes kehamilan serum bersama dengan USG. Jika mendapatkan hasil darah yang tidak menggumpal, segera mulai pengobatan.

c. Hiperemesis Gravidarum

Mual dan muntah adalah gejala umum pada trimester pertama kehamilan. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, gejala ini biasanya muncul 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan berlangsung selama 10 minggu. Rasa mual ini disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon estrogen dan *human chorionic gonadotropin* (HCG) di dalam serum.

d. Nyeri perut bagian bawah

Nyeri perut ini terjadi pada usia kehamilan 22 minggu dan mungkin merupakan gejala kehamilan

ektopik yang paling penting dan tanda-tanda penghentian kehamilan, termasuk nyeri perut, nyeri lemah, kelemahan rahim, perdarahan terus-menerus, kelemahan, lesu, demam, keputihan berbau, cairan serviks dan nanah, dan nyeri gerakan serviks.

2. Tanda-tanda dini bahaya/komplikasi ibu dan janin masa kehamilan lanjut

a. Perdarahan Pervaginam

Pendarahan vagina selama kehamilan jarang normal. Perdarahan pada akhir kehamilan atau setelah 20 minggu biasanya disebabkan oleh plasenta previa. Perdarahan yang terjadi sangat terkait dengan luas plasenta dan kondisi segmen bawah rahim yang menjadi tempat implementasi plasenta tersebut. Pada plasenta yang tipis dan menutupi sebagian besar plasenta maka umumnya terjadi perdarahan bercak berulang dan apabila segmen bawah rahim mulai terbentuk disertai dengan sedikit penurunan bagian terbawah janin maka perdarahan mulai meningkat hingga tingkatan yang dapat membahayakan keselamatan ibu.

Plasenta yang tebal yang menutupi seluruh jalan lahir dapat menimbulkan perdarahan hebat tanpa didahului oleh perdarahan bercak atau berulang sebelumnya. Plasenta previa menjadi penyebab dari 25% kasus perdarahan antepartum. Bila mendekati saat persalinan, perdarahan dapat disebabkan oleh solusio plasenta (40%) atau vasa previa (5%) dari keseluruhan kasus perdarahan antepartum. Gejala pada kehamilan ini, perdarahan merah segar, banyak, dan kadang-kadang, tetapi tidak selalu, disertai dengan rasa nyeri.

b. Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala bisa terjadi selama kehamilan, dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat (edema otak) yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadan-kadang dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari pre eklamsia.

c. Penglihatan kabur

Banyak anggota tubuh yang ikut berubah saat hamil, termasuk mata. Tak heran bila ibu hamil mengeluh kemampuan penglihatannya terganggu. Ada yang mengeluh lebih silau jika terkena cahaya, tidak nyaman dengan kacamata atau lensa kontak, pandangannya agak kabur, ada titik hitam di penglihatan, dan sebagainya. Perubahan yang terjadi pada mata ini, disebabkan adanya perubahan fisiologis maupun patologis.

d. Peningkatan tekanan darah dalam kehamilan

Penyakit peningkatan tekanan darah kehamilan adalah penyakit pembuluh darah yang terjadi sebelum kehamilan atau terjadi selama kehamilan atau awal persalinan. Kelompok penyakit ini ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan terkadang proteinuria, edema, kejang, koma, atau gejala lainnya.

Peningkatan tekanan darah selama kehamilan merupakan penyebab utama kematian pada bayi

baru lahir. Kematian bayi ini terutama karena kelahiran prematur akibat tekanan darah tinggi.

- 1) Peningkatan tekanan darah yang terjadi hanya pada masa kehamilan yaitu pre eklamsia dan eklamsia.
- 2) Diagnosis ditegakkan dengan peningkatan tekanan darah disertai proteinuria atau edema atau keduanya pada wanita hamil 22 minggu.
- 3) Peningkatan tekanan darah kronis (penyebab apapun). Diagnosis dibuat karena adanya peningkatan tekanan darah sebelum minggu ke-20 kehamilan dan peningkatan tekanan darah ini berlanjut setelah masa kehamilan.
- 4) Pre eklamsia dan eklamsia terjadi atas dasar peningkatan tekanan darah kronis. Penderita peningkatan tekanan darah kronis sering mengalami perburukan penyakitnya selama kehamilan dengan gejala peningkatan tekanan darah, proteinuria, edema dan kelainan retina.
- 5) Transient hypertension. Diagnosis dibuat ketika tekanan darah tinggi berkembang selama kehamilan atau dalam 24 jam pertama pada wanita yang tekanan darahnya normal dan membaik dalam 10 hari setelah melahirkan.

Bab 5

Persalinan

A. Pengertian Persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Proses ini dimulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati, yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta (Sulistyawati, 2013).

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan di mulai sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. (Sondakh, 2015).

B. Etiologi

Selama kehamilan, didalam tubuh perempuan terdapat dua hormon yang dominan yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas otot rahim serta memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin, dan mekanis. Sedangkan, hormon progesteron berfungsi untuk menurunkan sensitivitas otot rahim, menghambat rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin dan mekanis serta menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi (Sulistiyawati, dkk, 2013).

Sampai saat ini hal yang menyebabkan mulainya proses persalinan belum diketahui sehingga hanya ada teori-teori antara lain disebabkan oleh hormon, struktur rahim, sirkulasi rahim, pengaruh tekanan pada saraf, dan nutrisi. Dengan demikian dapat disebutkan beberapa teori yang dapat menyebabkan persalinan menurut Rohani (2013) sebagai berikut:

1. Teori Keregangan

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah batas waktu tersebut terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Keadaan uterus terus membesar dan menjadi tegang yang mengakibatkan iskemia otot-otot uterus.

2. Teori Penurunan Hormon progesteron

Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, dimana terjadi penimbunan jaringan ikat sehingga pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi hormon progesteron mengalami penurunan sehingga otot rahim lebih sensitive terhadap oksitosin. Akibatnya, otot rahim mulai berkontraksi

setelah tercapai tingkat penurunan hormon progesteron tertentu.

3. Teori Oksitosin Internal

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior. Perubahan keseimbangan hormon estrogen dan hormon progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim sehingga sering terjadi kontraksi *Braxton Hicks*. Menurunnya konsentrasi hormon progesteron akibat tuanya usia kehamilan menyebabkan oksitosin meningkatkan aktifitas sehingga persalinan dimulai.

4. Teori Prostaglandin

Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dapat dikeluarkan. Prostaglandin dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan.

C. Tanda Persalinan

Menjelang minggu ke 36 pada primigravida terjadi penurunan fundus uterus karena kepala bayi sudah masuk ke dalam pintu atas paggul (PAP). Gambaran *lightening* pada primigravida menunjukkan hubungan normal antara *power* (his) ; *passage* (jalan lahir) ; *passanger* (penumpang). Pada multipara gambarannya menjadi tidak jelas seperti primigravida, karena masuknya kepala janin ke dalam panggul terjadi bersamaan dengan proses persalinan (Sulistyawati, 2013). Berikut adalah tanda-tanda dimulainya persalinan menurut Jenny J.S Sondakh (2013):

1. Terjadinya his persalinan. Saat terjadi his ini pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan, sifatnya teratur, interval lebih pendek, dan kekuatan makin besar, serta

- semakin beraktivitas (jalan) kekuatan akan makin bertambah.
2. Pengeluaran lendir dengan darah. Terjadinya his persalinan mengakibatkan terjadinya perubahan pada serviks yang akan menimbulkan pendataran dan pembukaan. Hal tersebut menyebabkan lendir yang terdapat pada kanalis servikalis lepas dan pembuluh darah pecah sehingga terjadi perdarahan.
 3. Pada beberapa kasus persalinan akan terjadi pecah ketuban. Sebagian besar, keadaan ini terjadi menjelang pembukaan lengkap. Setelah adanya pecah ketuban, diharapkan proses persalinan akan berlangsung kurang dari 24 jam.
 4. Hasil-hasil yang didapatkan dari pemeriksaan dalam yakni pelunakan serviks, pendataran serviks, dan pembukaan serviks.

Tabel 5.1. Karakteristik Persalinan Sesungguhnya dan Persalinan Semu

Persalinan sesungguhnya	Persalinan semu
Serviks menipis dan membuka	Tidak ada perubahan pada serviks
Rasa nyeri dan interval teratur	Rasa nyeri tidak teratur
Interval antara rasa nyeri yang secara perlahan semakin pendek	Tidak ada perubahan interval antaras rasa nyeri yang satu dengan yang lain
Waktu dan kekuatan kontraksisemakin bertambah	Tidak ada perubahan pada waktudan kekuatan kontraksi
Rasa nyeri terasa dibagian belakangdan menyebar ke depan	Kebanyakan rasa nyeri di bagiandepan

Dengan berjalan bertambah intensitas	Tidak ada perubahan rasa nyeri dengan berjalan
Ada hubungan antara tingkat kekuatan kontraksi dengan intensitas nyeri	Tidak ada hubungan antara tingkat kekuatan kontraksi uterus dengan intensitas nyeri
Lendir darah sering tampak	Tidak ada lendir darah
Ada penurunan bagian kepala janin	Tidak ada kemajuan penurunan bagian terendah janin
Kepala janin sudah terfiksasi di PAP diantara kontraksi	Kepala belum masuk PAP walau ada kontraksi
Pemberian obat penenang tidak menghentikan proses persalinan sesungguhnya	Pemberian obat penenang yang efisien menghentikan rasa nyeri pada persalinan semula

Sumber: Sumarah, 2011

D. Tahapan Persalinan

Persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Pada kala I serviks membuka dari 0 sampai 10 cm. Kala I dinamakan juga kala pembukaan. Kala II dinamakan dengan kala pengeluaran karena kekuatan his dan kekuatan mengejan, janin di dorong keluar sampai lahir. Dalam kala III atau disebut juga kala urie, plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan. Kala IV mulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam kemudian (Sumarah, 2011).

Persalinan ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar kanalis servikalis karena pergeseran-

pergeseran ketika serviks mendatar dan membuka (Rohani, 2013).

Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0- 10 cm atau pembukaan lengkap. Proses ini terjadi dua fase yakni fase laten selama 8 jam dimana serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif selama 7 jam dimana serviks membuka dari 3-10 cm. Kontraksi lebih kuat dan sering terjadi selama fase aktif. Pada permulaan his kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga *parturient* atau ibu yang sedang bersalin masih dapat berjalam-jalan (Sulistyawati, 2013).

Kala II merupakan kala pengeluaran bayi dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Uterus dengan kekuatan hisnya ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Diagnosis persalinan ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm (Sulistyawati, 2013).

Gejala utama kala II menurut Jenny J.S Sondakh (2013) yakni:

His semakin kuat dengan interval 2 sampai 3 menit dengan durasi 50 sampai 100 detik.

1. Menjelang akhir kala I ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak.
2. Ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap diikuti keinginan untuk mengejan akibat tertekannya pleksus frankenhauser.
3. Kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga kepala membuka pintu, subocciput bertindak sebagai hipoglobin kemudian secara berturut-

turut lahir ubun-ubun besar, dahi, hidung dan muka, serta kepala seluruhnya.

4. Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar, yaitu penyesuaian kepala pada punggung.
5. Setelah putar paksi luar berlangsung maka persalinan bayi ditolong dengan cara memegang kepala pada bagian belakang dan di bawah dagu, kemudian ditarik dengan menggunakan cunam ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir ketiak dikait untuk melahirkan sisa badan bayi, kemudian bayi lahir diikuti oleh sisa air ketuban.

Kala III adalah waktu untuk pelepasan plasenta dan pengeluaran plasenta. Setelah kala II yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 sampai 10 menit. Dengan lahirnya bayi dan proses retraksi uterus, maka plasenta lepas dari lapisan nitabusch. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda- tanda sebagai berikut:

1. Uterus menjadi berbentuk bundar
2. Uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim
3. Tali pusat bertambah panjang
4. Terjadi perdarahan

Plasenta dan selaput ketuban harus diperiksa secara teliti setelah dilahirkan, bagian plasenta lengkap atau tidak. Bagian permukaan maternal yang normal memiliki 6 sampai 20 kotiledon. Jika plasenta tidak lengkap maka disebut ada sisa plasenta serta dapat mengakibatkan perdarahan yang banyak dan infeksi (Sondakh, 2013).

Kala IV dimulai dari lahirnya plasenta selama 1 sampai 2 jam. Pada kala IV dilakukan observasi terhadap

perdarahan pascapersalinan, paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan menurut Sulistyawati (2013) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran pasien.
2. Pemeriksaan tanda-tanda vital yakni tekanan darah, nadi, dan pernafasan.
3. Kontraksi uterus.
4. Terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masih normal bila jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc.

E. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan

Menurut Sulistyawati (2013) faktor yang mempengaruhi persalinan adalah

1. *Power* (Kekuatan Ibu)

Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen. Kekuatan primer yang diperlukan dalam persalinan adalah his, sedangkan sebagai kekuatan sekundernya adalah tenaga meneran ibu.

His atau kontraksi uterus adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan. His dibedakan menjadi dua yakni his pendahuluan dan his persalinan. His pendahuluan atau his palsu (*false labor pains*), yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi *braxton hicks*. His ini bersifat tidak teratur dan menyebabkan nyeri di perut bagian bawah dan lipat paha, tidak menyebabkan nyeri yang memancar dari pinggang ke perut bagian bawah. His pendahuluan tidak mempunyai pengaruh terhadap serviks. His persalinan merupakan suatu kontraksi dari otot-otot rahim yang fisiologis, akan tetapi bertentangan dengan kontraksi fisiologis lainnya dan bersifat nyeri.

Kontraksi rahim bersifat otonom yang artinya tidak dipengaruhi oleh kemauan, namun dapat dipengaruhi dari luar misalnya rangsangan oleh jari-jari tangan (Rohani, 2013).

Tenaga meneran ini serupa dengan tenaga meneran saat buang air besar, tetapi jauh lebih kuat lagi. Ketika kepala sampai pada dasar panggul, timbul suatu reflek yang mengakibatkan pasien menekan diafragmanya kebawah. Tenaga meneran pasien akan menambah kekuatan kontraksi uterus. Pada saat pasien meneran, diafragma dan otot-otot dinding abdomen akan berkontraksi. Kombinasi antara his dan tenaga meneran pasien akan meningkatkan tekanan intrauterus sehingga janin akan semakin terdorong keluar.

Kekuatan sekunder tidak mempengaruhi dilatasi serviks, tetapi setelah dilatasi serviks lengkap, kekuatan ini cukup penting untuk mendorong janin keluar. Apabila dalam persalinan melakukan *valsa maneuver* (meneran) terlalu dini, dilatasi serviks akan terhambat. Meneran akan menyebabkan ibu lelah dan menimbulkan trauma serviks.

2. *Passage* (Jalan Lahir)

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan introitus (lubang vagina). Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya dengan jalan lahir yang relatif kaku. Oleh karena itu ukuran dan bentuk panggul harus ditentukan sebelum persalinan dimulai.

Tulang ilium atau tulang usus merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Bagian atas merupakan penebalan tulang yang disebut krista iliaka. Ujung depan dan

belakang krista iliaka yang menonjol yakni spina iliaka anterosuperior dan spina iliaka postesuperior. Terdapat benjolan tulang memanjang di bagian dalam tulang ilium yang membagi pelvis mayor dan minor, disebut linea inominata atau linea terminalis yang merupakan bagian dari pintu atas panggul.

Tulang isikum atau tulang duduk terdapat di sebelah bawah tulang usus, sebelah samping belakang menonjol yang disebut spina ichiadika. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal (tuber ichiadika) yang berfungsi menopang badan saat duduk.

Tulang pubis atau tulang kemaluan terdapat di sebelah bawah dan depan tulang ilium dengan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatorium. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior tulang pubis. Di depan kedua tulang ini berhubungan melalui artikulasi atau sambungan yang disebut simfisis.

Tulang sakrum atau tulang kelangkangan yang terletak diantara kedua tulang pangkal paha. Tulang ini berbentuk segitiga dengan lebar di bagian atas dan mengecil di bagian bawah. Tulang sakrum terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Permukaan depan licin dengan lengkungan dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Pada sisi kanan dan kiri di garis tengah terdapat lubang yang dilalui oleh saraf yang disebut foramen sakralia anterior. Tulang kelangkang yang paling atas mempunyai tonjolan besar ke depan yang disebut promontorium. Bagian samping tulang kelangkang berhubungan dengan tulang pangkal paha melalui artikulasi sarco-iliaca. Ke bawah tulang kelangkang berhubungan dengan tulang tungging atau tulang

koksigis.

Tulang koksigis atau tulang tungging merupakan tulang yang berbentuk segitiga dengan ruas 3 sampai 5 buah yang menyatu. Pada tulang ini terdapat hubungan antara tulang sakrum dengan tulang koksigis yang disebut artikulasi sarco-koksigis. Diluar kehamilan artikulasi hanya memungkinkan mengalami sedikit pergeseran, tetapi pada kehamilan dan persalinan dapat mengalami pergeseran yang cukup longgar bahkan ujung tulang koksigis dapat bergerak ke belakang sampai sejauh 2,5 cm pada proses persalinan.

Panggul memiliki empat bidang yang menjadi ciri khas dari jalan lahir yakni pintu atas panggul (PAP), bidang terluas panggul, bidang tersempit panggul, dan pintu bawah panggul. Jalan lahir merupakan corong yang melengkung ke depan panjangnya 4,5 cm dan belakang 12,5 cm. Pintu atas panggul menjadi pintu bawah panggul seolah-olah berputar 90 derajat terjadi pada bidang tersempit panggul. Pintu bawah panggul bukan merupakan satu bidang tetapi dua bidang segitiga.

Pintu atas panggul (PAP) merupakan bagian dari pelvis minor yang terbentuk dari promontorium, tulang sakrii, linea terminalis, dan pinggir atas simfisis. Jarak antara simfisis dan promontorium sekitar 11 cm. Yang disebut konjungata vera. Jarak terjauh garis melintang pada PAP adalah 12,5 sampai 13 cm yang disebut diameter transversa. Bidang dengan ukuran terbesar atau bidang terluas panggul merupakan bagian yang terluas dan berbentuk seperti lingkaran. Bidang ini memiliki batas anterior yakni pada titik tengah permukaan belakang tulang pubis. Pada lateral sepertiga bagian atas dan tengah foramen obturatorium, sedangkan batas

posterior pada hubungan antara vertebra sakralis kedua dan ketiga.

Bidang dengan ukuran terkecil atau bidang tersempit panggul merupakan bidang terpenting dalam panggul yang memiliki ruang yang paling sempit dan di tempat ini paling sering terjadi macetnya persalinan. Bidang ini terbentang dari apeks sampai arkus subpubis melalui spina ichiadika ke sakrum, biasanya dekat dengan perhubungan antara vertebra sakralis ke 4 dan ke 5. Bidang tersempit panggul memiliki batas-batas yakni pada tepi bawah simfisis pubis, garis putih pada fasia yang menutupi foramen obturatorium, spina ischiadika, ligamentum sacrospinus, dan tulang sakrum.

Pintu bawah panggul ialah batas bawah panggul sejati. Dilihat dari bawah, struktur ini berbentuk lonjong, seperti intan, di bagian anterior dibatasi oleh lengkung pubis, di bagian lateral dibatasi oleh tuberosita isikum, dan dibagian posterior dibatasi oleh ujung koksigeum.

Bidang hodge berfungsi untuk menentukan sampai dimana bagian terendah janin turun ke panggul pada proses persalinan. Bidang hodge tersebut antara lain:

- a. Hodge I merupakan bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium
- b. Hodge II yakni bidang yang sejajar Hodge I setinggi bagian bawah simfisis
- c. Hodge III yakni bidang yang sejajar Hodge I setinggi spina ischiadika
- d. Hodge IV merupakan bidang yang sejajar Hodge I setinggi tulang koksigis (Sulistyawati, 2013).

3. *Passanger* (Janin dan Plasenta)

Perubahan mengenai janin sebagai *passenger* sebagian besar dalah mengenai ukuran kepala janin, karena kepala merupakan bagian terbesar dari janin dan paling sulit untuk dilahirkan. Adanya celah antara bagian- bagian tulang kepala janin memungkinkan adanya penyisipan antara bagian tulang sehingga kepala janin dapat mengalami perubahan bentuk dan ukuran, proses ini disebut *molase* (Sulistyawati, 2013).

Menurut Sulistyawati (2013), Plasenta dan tali pusat memiliki struktur berbentuk bundar atau hampir bundar dengan diameter 15 cm sampai 20 cm dan tebal 2 cm sampai 2 sampai 2,5 cm, berat rata-rata 500 gram, terletak di depan atau di belakang dinding uterus ke atas arah fundus. Bagian plasenta yang menempel pada desidua terdapat kotiledon disebut *pers maternal*, dan dibagian ini tempat terjadinya pertukaran darah ibu dan janin. Tali pusat merupakan bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup janin meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa tali pusat juga menyebabkan penyulit persalinan misalnya pada kasus lilitan tali pusat (Sulistyawati, 2013).

Air ketuban atau *amnion* merupakan elemen yang penting dalam proses persalinan. Air ketuban ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan diagnosa kesejahteraan janin. *Amnion* melindungi janin dari trauma atau benturan, memungkinkan janin bergerak bebas, menstabilkan suhu tubuh janin agar tetap hangat, menahan tekanan uterus, dan pembersih jalan lahir (Sulistyawati, 2013).

4. Psikologis

Faktor psikologis menurut Rohani (2013) yakni:

- a. Melibatkan psikologis ibu, emosi, dan persiapan intelektual
- b. Pengalaman melahirkan bayi sebelumnya
- c. Kebiasaan adat
- d. Dukungan orang terdekat pada kehidupan ibu

5. Penolong

Peran dari penolong persalinan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin, dalam hal ini tergantung dari kemampuan dan kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan (Rohani, 2013).

F. Kebutuhan Dasar Selama Persalinan

Selama proses persalinan, pasien sangat membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, yang dimaksud kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang sangat penting dan mutlak untuk dipenuhi selama proses persalinan antara lain:

1. Makan dan minum per oral.

Pemberian makanan pada pasien yang kemungkinan sewaktu-waktu memerlukan tindakan anestesi tidak disetujui, karena makanan yang tertinggal di lambung akan menyebabkan aspirasi pneumoni. Dikarenakan pada proses persalinan, motilitas lambung; absorpsi lambung; dan sekresi asam lambung menurun. Sedangkan cairan tidak terpengaruh dan akan meninggalkan lambung dengan durasi waktu yang biasa, oleh karena itu pada pasien sangat dianjurkan untuk minum cairan yang manis dan berenergi sehingga kebutuhan kalornya akan tetap terpenuhi.

2. Akses intravena

Akses intravena adalah tindakan pemasangan infus pada pasien. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan sebagai jalur obat, cairan, darah untuk mempertahankan keselamatan jiwa sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat dan untuk mempertahankan suplai cairan bagi pasien

3. Posisi dan ambulasi

Posisi yang nyaman sangat diperlukan bagi pasien. Selain mengurangi ketegangan dan rasa nyeri, posisi tertentu justru akan membantu proses penurunan kepala janin sehingga persalinan dapat berjalan lebih cepat (selama tidak ada kontra indikasi dari keadaan pasien). Beberapa posisi yang dapat diambil antara lain rekumben lateral (miring), lutut-dada, tangan-lutut, duduk, berdiri, berjalan, dan jongkok.

4. Eliminasi selama persalinan (BAB atau BAK)

a. Buang Air Kecil (BAK)

Selama proses persalinan, pasien akan mengalami poliuri sehingga penting untuk difasilitasi agar kebutuhan eliminasi dapat terpenuhi. Jika pasien masih berada dalam awal kala I, ambulasi dengan berjalan seperti aktivitas ke toilet akan membantu penurunan kepala janin. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri untuk kemajuan persalinannya.

b. Buang Air Besar (BAB)

Pasien akan merasa sangat tidak nyaman ketika merasakan dorongan untuk BAB. Namun rasa khawatir akan lebih mendominasi daripada perasaan tidak nyaman, hal ini terjadi karena pasien tidak tau mengenai caranya serta khawatir akan respon orang

lain terhadap kebutuhannya ini. Dalam kondisi ini penting bagi keluarga dan bidan untuk menunjukkan respon yang positif dalam hal kesiapan untuk memberikan bantuan dan meyakinkan pasien bahwa ia tidak perlu merasa risih atau sungkan untuk melakukannya. (Sulistyawati, 2013)

Menurut Rohani (2013) kebutuhan dasar selama persalinan yaitu:

1. Asuhan Tubuh dan Fisik

- a. Menjaga kebersihan diri. Menganjurkan ibu untuk membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil atau buang air besar dan menjaga agar tetap bersih dan kering.
- b. Berendam dapat menjadi tindakan pendukung dan kenyamanan yang paling menenangkan.
- c. Perawatan mulut untuk mencegah bau mulut.
- d. Pengipasan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan ibu yang disebabkan oleh keringat.

2. Kehadiran Seorang Pendamping

Fungsi hadirnya seorang pendamping pada saat persalinan yakni mengurangi rasa sakit, membuat waktu persalinan lebih singkat, dan menurunkan kemungkinan persalinan dengan operasi. Pendamping persalinan bisa ditemani oleh suami, anggota keluarga, atau teman yang ibu inginkan selama proses persalinan.

3. Pengurangan Rasa Nyeri

Pengendalian rasa nyeri dapat dilakukan dengan memberikan kompres panas dan dingin. Kompres panas meningkatkan suhu kulit lokal, mengurangi spasme otot, dan meningkatkan ambang nyeri. Sedangkan kompres dingin, berguna untuk mengurangi ketegangan nyeri

sendi dan otot, mengurangi pembengkakan, dan menyejukkan kulit.

4. Penerimaan Terhadap Kelakuan dan Tingkah Lakunya
Persalinan dan kelahiran merupakan hal yang fisiologis namun banyak wanita yang tidak siap untuk menghadapi persalinannya. Wanita biasanya membutuhkan perhatian dari suami atau keluarganya, bahkan bidan sebagai penolong persalinan.
5. Informasi dan Kepastian Tentang Hasil Persalinan yang Aman
Setiap ibu membutuhkan informasi tentang kemajuan persalinannya, sehingga ia mampu mengambil keputusan dan juga perlu diyakinkan bahwa kemajuan persalinannya normal.

G. Persalinan Kala I

Menurut Sumarah (2011), pada persalinan kala I terjadi perubahan fisiologis dan psikologis seperti berikut:

1. Perubahan Fisiologis Kala I
 - a. Tekanan Darah
Tekanan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan kenaikan sistolik rata-rata 10 sampai 20 mmHg dan kenaikan diastolik rata-rata 5 sampai 10 mmHg. Diantara kontraksi-kontraksi uterus, tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan dan akan naik lagi bila terjadi kontraksi.
 - b. Metabolisme
Selama persalinan baik metabolisme karbohidrat aerobik maupun anaerobik akan naik secara perlahan. Kenaikan ini disebabkan oleh kecemasan serta kegiatan otot kerangka tubuh.

c. Suhu Badan

Suhu badan sedikit meningkat selama persalinan dan suhu akan mencapai tertinggi selama persalinan maupun setelah persalinan. Kenaikan normal selama tidak melebihi 0,5 hingga 1 derajat celcius.

d. Denyut Jantung

Denyut jantung diantara kontraksi sedikit lebih tinggi dibanding selama periode persalinan atau sebelum masuk persalinan. Denyut jantung yang sedikit naik merupakan kenaikan yang normal, meskipun demikian perlu pemeriksaan secara berkala untuk mengidentifikasi adanya infeksi

e. Pernafasan

Pernafasan terjadi kenaikan sedikit dibanding dengan sebelum persalinan yang disebabkan adanya rasa nyeri, kekhawatiran serta penggunaan teknik pernafasan yang salah.

f. Perubahan Renal

Poliuri sering terjadi selama persalinan, hal ini disebabkan oleh kardiak output yang meningkat, serta disebabkan karena filtrasi glomerulus serta aliran plasma ke renal. Protein urine (+1) selama persalinan adalah hal yang fisiologis namun proteinuri (+2) merupakan hal yang tidak wajar.

g. Perubahan Gastrointestinal

Kemampuan pergerakan gastrik serta penyerapan makanan padat berkurang akan menyebabkan pencernaan hampir berhenti selama persalinan dan menyebabkan konstipasi.

h. Perubahan Hematologis

Hemoglobin akan meningkat 1,2 gram/100 ml selama persalinan dan kembali ketingkat pra

persalinan pada hari pertama setelah persalinan apabila tidak terjadi kehilangan darah selama persalinan. Jumlah sel- sel darah putih meningkat secara progresif selama kala satu persalinan sebesar 5000 sampai 15.000 WBC hingga akhir pembukaan lengkap, hal ini tidak berindikasi adanya infeksi. Setelah itu turun kembali keadaan semula.

i. Kontraksi Uterus

Kontraksi uterus terjadi karena adanya rangsangan pada otot polos uterus dan penurunan hormon progesteron yang menyebabkan keluarnya hormon oksitosin. Kontraksi uterus dimulai dari fundus uteri menjalar ke bawah dan bekerja kuat serta lama untuk mendorong janin ke bawah. Sedangkan uterus bagian bawah pasif hanya mengikuti tarikan dengan segmen atas rahim, akhirnya menyebabkan serviks menjadi lembek dan membuka. Kerjasama antara uterus bagian atas dan bagian bawah disebut polaritas.

j. Pembentukan Segmen Atas Rahim dan Segmen Bawah Rahim

Segmen atas rahim (SAR) terbentuk pada uterus bagian atas dengan sifat otot yang lebih tebal dan kontraksi. Pada bagian ini terdapat banyak otot serong dan memanjang. SAR terbentuk dari fundus sampai ishmus uteri. Segmen bawah rahim (SBR) terbentang di uterus bagian bawah antara ishmus dengan serviks, dengan sifat otot yang tipis dan elastis, pada bagian ini banyak terdapat otot yang melingkar dan memanjang.

k. Perkembangan Retraksi Ring

Retraksi ring adalah batas pinggiran antara SAR dan SBR, dalam keadaan persalinan normal tidak nampak dan akan kelihatan pada persalinan abnormal, karena kontraksi uterus yang berlebihan, retraksi ring akan tampak sebagai garis atau batas yang menonjol di atas simpisis yang merupakan tanda dan ancaman ruptur uteris.

l. Penarikan Serviks

Pada akhir kehamilan otot yang melindungi ostium uteri internum (OUI) ditarik SAR yang menyebabkan serviks menjadi pendek dan menjadi pendek dan menjadi bagian dari SBR. Bentuk serviks menghilang karena kanalis servikalis membesar dan atas membentuk ostium uteri eksterna (OUE) sebagai ujung dan bentuknya menjadi sempit.

m. Pembentukan Ostium Uteri Interna dan Ostium Uteri Eksterna

Pembukaan serviks disebabkan oleh karena membesarnya OUE karena otot yang melingkar disekitar ostium meregang untuk dapat dilewati kepala. Pembukaan uteri tidak saja karena penarikan SAR akan tetapi juga karena tekanan isi uterus yaitu kepala dan kantong amnion. Pada primigravida dimulai dari OUI terbuka terlebih dahulu baru OUE membuka pada saat persalinan terjadi. Sedangkan pada multigravida ostium uteri internum dan eksternum membuka secara bersama-sama pada saat persalinan terjadi.

n. Show

Show adalah pengeluaran dari vagina yang terdiri dan sedikit lendir yang bercampur darah, lendir ini berasal dan ekstruksi lendir yang menyumbat kanalis servikalis sepanjang kehamilan sedangkan darah berasal dan desidua vera yang lepas.

o. Tonjolan Kantong Ketuban

Tonjolan kantong ketuban ini disebabkan oleh adanya regangan SBR yang menyebabkan terlepasnya selaput korion yang menempel pada uterus, dengan adanya tekanan maka akan terlihat kantong yang berisi cairan yang menonjol ke ostium uteri internum yang terbuka. Cairan ini terbagi dua yaitu *fore water* dan *hind water* yang berfungsi untuk melindungi selaput amnion agar tidak terlepas seluruhnya. Tekanan yang diarahkan ke cairan sama dengan tekanan ke uterus sehingga akan timbul generasi fluid pressure. Bila selaput ketuban pecah maka cairan tersebut akan keluar, sehingga plasenta akan tertekan dan menyebabkan fungsi plasenta terganggu. Hal ini akan menyebabkan fetus kekurangan oksigen.

p. Pemecahan Kantong Ketuban

Pada akhir kala satu bila pembukaan sudah lengkap dan tidak ada tahanan lagi, ditambah dengan kontraksi yang kuat serta desakan janin yang menyebabkan kantong ketuban pecah, diikuti dengan proses kelahiran bayi.

2. Perubahan Psikologis Kala I

Pada setiap tahap persalinan, pasien akan mengalami perubahan psikologis dan perilaku yang cukup spesifik sebagai respond dari apa yang ia rasakan dari proses

persalinannya.

3. Penggunaan Partograf

a. Pemantauan partograf

Partograf merupakan alat bantu yang digunakan untuk memantau kemajuan kala I persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik.

b. Fungsi partograf

- 1) Mengamati dan mencatat informasi kemajuan persalinan dengan memeriksa dilatasi serviks selama pemeriksaan dalam.
- 2) Mendeteksi secara dini terhadap kemungkinan adanya penyulit persalinan sehingga bidan dapat membuat keputusan tindakan dengan tepat.
- 3) Sebagai alat komunikasi yang unik namun praktis antar bidan atau antara bidan dengan dokter mengenai perjalanan persalinan pasien.
- 4) Alat dokumentasi riwayat persalinan pasien beserta data pemberian medika mentosa yang diberikan selama proses persalinan.

c. Kriteria pasien yang dipantau menggunakan partograf

- 1) Persalinan diperkirakan spontan.
- 2) Janin tunggal.
- 3) Usia kehamilan 36-42 minggu.
- 4) Presentasi kepala.
- 5) Tidak ada penyulit persalinan.
- 6) Persalinan sudah masuk dalam kala I fase aktif.

H. Persalinan Kala II

1. Perubahan Fisiologis Kala II menurut Sulistyawati (2013)
 - a. Uterus
Saat ada his, uterus teraba saat keras karena seluruh otot berkontraksi.
 - b. Serviks
Pada kala II, serviks sudah menipis dan dilatasi maksimal. Saat dilakukan pemeriksaan dalam porsio sudah tidak teraba pada pembukaan 10 cm.
 - c. Pergeseran organ dasar panggul
Tekanan otot dasar panggul oleh kepala janin akan menyebabkan pasien ingin meneran, sert diikuti dengan perineum yang menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka.
 - d. Ekspulsi janin
Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala janin sudah tidak masuk lagi diluar his. Dengan his serta kekuatan meneran maksimal, kepala janin dilahirkan dengan suboksiput dibawah simfisis, kemudian dahi, muka dan dagu melewati perineum.
 - e. Tekanan Darah
Tekanan darah dapat meningkat lagi 15-25 mmHg selama kala II persalinan. Upaya meneran juga akan memengaruhi tekanan darah, dapat meningkat kemudian menurun kemudian akhirnya kembali lagi sedikit di atas normal.
 - f. Metabolisme
Peningkatan metabolisme terus berlanjut hingga kala II persalinan. Upaya meneran dapat menambah aktivitas otot-otot rangka sehingga meningkatkan metabolisme.

- g. Denyut Nadi
Frekuensi denyut nadi bervariasi tiap kali pasien meneran. Secara keseluruhan frekuensi nadi meningkat selama kala II disertai takikardi yang nyata ketika mencapai puncak menjelang kelahiran.
 - h. Suhu
Peningkatan suhu tertinggi terjadi saat proses persalinan dan segera setelahnya, peningkatan suhu normal yaitu $0,5^{\circ}-1^{\circ}\text{C}$.
 - i. Pernapasan
Pernapasan sama seperti pada saat kala I persalinan.
 - j. Perubahan Gastrointestinal
Penurunan motilitas lambung dan absorpsi yang hebat terlanjur sampai kala II. Biasanya mual dan muntah pada saat transisi akan mereda selama kala II persalinan, tetapi bisa terus ada pada beberapa pasien. Muntah dan konstan selama persalinan merupakan hal yang abnormal dan mungkin merupakan indikasi dari komplikasi obstetrik, seperti ruptur uterus atau toksemia.
2. Mekanisme Persalinan Normal menurut Sulistyawati (2013) yakni:
- a. Penurunan kepala
Terjadi selama proses persalinan karena daya dorong dari kontraksi uterus yang efektif, posisi, serta kekuatan meneran dari pasien.
 - b. Penguncian (engagement)
Tahap penurunan pada waktu diameter biparietal dari kepala janin telah melalui lubang masuk panggul pasien.
 - c. Fleksi
Dalam proses masuknya kepala janin ke dalam

panggul, fleksi menjadi hal yang sangat penting karena dengan fleksi diameter kepala janin terkecil dapat bergerak melalui panggul dan terus menuju dasar panggul. Pada saat kepala bertemu dengan dasar panggul, tahanannya akan meningkatkan fleksi menjadi bertambah besar yang sangat diperlukan agar saat sampai di dasar panggul kepala janin sudah dalam keadaan fleksi maksimal.

d. Putaran paksi dalam (rotasi dalam)

Putaran paksi dalam merupakan pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala, bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil dan bagian inilah yang akan memutar ke depan arah simfisis. Rotasi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan karena merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir khususnya bidang tengah dan pintu bawah panggul (Rohani, 2013:148).

e. Lahirnya kepala secara ekstensi

Proses ini terjadi karena gaya tahanan dari dasar panggul, dimana gaya tersebut membentuk lengkungan carus yang mengarahkan kepala ke atas menuju lorong vulva. Bagian leher belakang di bawah oksiput akan bergeser ke bawah simfisi pubis dan bekerja sebagai titik poros (hipomoklion). Uterus yang berkontraksi memberikan tekanan tambahan dikepala yang menyebabkan ekstensi lebih lanjut saat lubang vulva-vagina membuka lebar.

f. Restitusi

Restitusi merupakan perputaran kepala sebesar 45

derajat baik ke kanan atau ke kiri, bergantung pada arah mengikuti perputaran menuju posisi oksiput anterior.

g. Putaran paksi luar

Putaran ini terjadi secara bersamaan dengan putaran internal dari bahu. Pada saat kepala janin mencapai dasar panggul, bahu akan mengalami perputaran dalam arah yang sama dengan kepala janin agar terletak dalam diameter yang besar dari rongga panggul. Bahu anterior akan terlihat pada lubang vulva-vagina dan bergeser dibawah simfisis pubis.

h. Lahirnya bahu dan seluruh anggota badan bayi

Bahu posterior akan menggembungkan perineum dan kemudian dilahirkan dengan cara fleksi lateral. Setelah bahu dilahirkan, seluruh tubuh janin lainnya akan dilahirkan mengikuti jalan lahir.

I. Persalinan Kala III

1. Fisiologi Kala III

Kala III merupakan periode penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlengketaan plasenta. Karena tempat perlengketaan menjadi kecil, sedangkan ukuran lasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas plasenta akan turun ke bawah bagian bawah uterus atau kedalam vagina.

2. Macam-macam Pelepasan Plasenta menurut Rohani (2013):

a. Mekanisme Schultz

Pelepasan plasenta yang dimulai dari bagian tengah

sehingga terjadi bekuan retroplasenta.

b. Mekanisme Duncan

Terjadi pelepasan plasenta dari pinggir atau bersamaan dari pinggir dan tengah plasenta. Hal ini mengakibatkan terjadi semburan darah sebelum plasenta lahir.

3. Tanda-tanda Pelepasan Plasenta

- a. Perubahan bentuk uterus dari diskoid menjadi globuler akibat dari kontraksi uterus.
- b. Semburan darah tiba-tiba.
- c. Tali pusat memanjang.
- d. Perubahan posisi uterus, setelah plasenta lepas dan menempati segmen bawah rahim, maka uterus muncul pada rongga abdomen.

4. Pengeluaran Plasenta

Plasenta yang sudah lepas dan menempati segmen bawah rahim, kemudian melalui serviks, vagina dan dikeluarkan ke intruitus vagina (Sumarah, 2011).

5. Pemeriksaan Pelepasan Plasenta menurut Sulistywati (2013):

a. Perasat Kustner

Tangan kanan meregangkan atau menarik sedikit tali pusat, sementara kanan kiri menekan atas simfisis. Bila tali pusat masuk kembali kedalam vagina berarti plasenta belum lepas, bila plasenta tetap atau tidak masuk kembali ke dalam vagina berarti plasenta belum lepas.

b. Perasat Strassman

Perasat ini dilakukan dengan mengetok-ngetok fundus uterus dengan tangan kiri dan tangan kanan meregangkan tali pusat sambil merasakan apakah ada getaran yang diimbulkan dari gerakan

tangan kiri. Jika terasa ada getaran, maka plasenta belum lepas dari dinding uterus, jika tidak terasa getaran berarti plasenta sudah lepas.

c. Perasat Klein

Untuk melakukan perasat ini, minta pasien untuk meneran, jika tali pusat tampak turun atau bertambah panjang berarti plasenta telah lepas, begitu juga sebaliknya.

6. Manajemen Aktif kala III menurut Sulistyawati (2013) adalah:

a. Definisi

Manajemen aktif kala III adalah mengupayakan kala III selesai secepat mungkin dengan melakukan langkah-langkah yang memungkinkan plasenta lepas dan lahir lebih cepat.

b. Tujuan

- 1) Mengurangi kejadian perdarahan pasca melahirkan.
- 2) Mengurangi lamanya kala III.
- 3) Mengurangi penggunaan tranfusi darah.
- 4) Mengurangi penggunaan oksitosin.

c. Komponen Manajemen Aktif Kala III

- 1) Pemberian oksitosin IM (Intramuskular) segera setelah bayi lahir maksimal 2 menit.
- 2) Tali pusat diklem.
- 3) Plasenta dilahirkan melalui peregangan tali pusat terkendali dengan menahan fundus uterus secara dorsokranial (arah ke atas dan ke belakang).
- 4) Setelah plasenta dilahirkan, lakukan masase pada fundus uterus secara sirkular agar uterus tetap berkontraksi dengan baik serta untuk mendorong ke luar setiap gumpalan darah yang ada dalam

uterus.

7. Kebutuhan Ibu Bersalin Kala III menurut Sulistyawati (2013):
 - a. Dukungan mental dari bidan dan keluarga atau pendamping.
 - b. Penghargaan terhadap proses kelahiran janin yang telah dilalui.
 - c. Informasi yang jelas mengenai keadaan pasien sekarang atau tindakan yang akan dilakukan.
 - d. Penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan ibu untuk membantu mempercepat kelahiran plasenta, yaitu kapan saat meneran dan posisi yang mendukung untuk pelepasan dan kelahiran plasenta.
 - e. Bebas dari rasa tidak nyaman akibat bagian bawah yang basah oleh darah dan air ketuban.
 - f. Hidrasi

J. Persalinan Kala IV

1. Fisiologi Kala IV menurut Sulistyawati (2013) yaitu:
 - a. Tanda Vital
Dalam dua jam pertama setelah persalinan, tekanan darah, nadi, dan pernapasan akan berangsur kembali normal.
 - b. Gemetar
Gemetar terjadi akibat hilangnya ketegangan dan sejumlah energi selama melahirkan dan merupakan respon fisiologis terhadap penurunan volume intraabdominal serta pergeseran hematologi.
 - c. Sistem Gastrointestinal
Selama dua jam pascapersalinan kadang pasien merasa mual dan muntah, atasi hal ini dengan posisi tubuh yang memungkinkan dapat mencegah

terjadinya aspirasi corpus aleanum ke saluran pernapasan dengan setengah duduk atau duduk di tempat tidur.

d. Sistem Renal

Selama 2-4 jam pascapersalinan kandung kemih masih dalam keadaan hipotonik akibat adanya alostaktis, sehingga sering dijumpai kandung kemih dalam keadaan penuh dan mengalami pembesaran. Hal ini disebabkan adanya tekanan pada kandung kemih dan uretra selama persalinan.

e. Sistem Kardiovaskular

Selama kehamilan, volume darah normal digunakan untuk menampung aliran darah yang meningkat yang diperlukan oleh plasenta dan pembuluh darah uterus. Pada persalinan per vagina kehilangan darah sekitar 200 ml – 500 ml, sedangkan pada persalinan SC pengeluaran dua kali lipat. Perubahan terdiri dari volume darah dan kadar Hematokrit.

f. Serviks

Perubahan pada serviks terjadi setelah bayi lahir, bentuk serviks menganga seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uterus yang dapat berkontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks terbentuk seperti cincin.

g. Perineum

Setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Pada hari ke lima pascamelahirkan, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya sekalipun tetap lebih kendur dibandingkan keadaan sebelum hamil.

h. Vulva dan Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. Selama 3 minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil.

i. Pengeluaran ASI

Dengan menurunnya hormon estrogen, hormon progesteron, dan *Human Placenta Lactogen Hormon* setelah plasenta lahir, prolaktin dapat berfungsi membentuk Air Susu Ibu (ASI) dan mengeluarkannya ke dalam alveoli bahkan sampai duktus kelenjar ASI.

2. Evaluasi Uterus

a. Konsistensi

Setelah plasenta lahir, dilakukan evaluasi konsistensi uterus sambil melakukan masase untuk mempertahankan kontraksinya.

b. Atonia

1) Konsistensi uterus.

2) Hal yang perlu diperhatikan terhadap kemungkinan relaksasi uterus

a) Riwayat atonia pada persalinan sebelumnya.

b) Status pasien sebagai grande multipara.

c) Distensi berlebihan pada uterus misalnya pada kehamilan kembar, polihidramnion, atau makrosomia.

d) Induksi persalinan.

e) Persalinan memanjang.

3) Kelengkapan plasenta dan membran.

4) Status kandung kemih

Bab 6

Penutup

Dukungan keluarga sangat penting bagi ibu hamil karena dapat memberikan rasa nyaman dan aman, serta mengurangi rasa cemas. Dukungan keluarga dapat berupa Membantu mengurus urusan rumah tangga, Mendengarkan keluhan ibu hamil, Memberikan semangat, memonitor asupan gizi, Menciptakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan, Memperhatikan waktu istirahat, Mengajak ibu hamil melakukan aktivitas ringan, Membantu meringankan keluhan ibu hamil, seperti memijat punggung, Memberikan pujian kepada ibu hamil, Membantu mengatasi masalah sulit tidur.

Dukungan keluarga dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis bagi ibu hamil. Dukungan keluarga juga dapat mempengaruhi kesiapan ibu menghadapi kehamilan dan persalinan. Selama masa kehamilan, perempuan membutuhkan dukungan dari keluarga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi ibu dan janin. Distres emosional pada perempuan selama kehamilan terbukti meningkatkan risiko hasil yang buruk bagi perempuan dan bayi baru lahir. Angka kematian ibu sangat tinggi.

Melalui buku ini dapat memberikan literasi pada keluarga dalam memberikan dukungan pada ibu hamil terutama pada ibu hamil pertama kali atau primigravida, buku ini juga dapat menjadi literasi bagi institusi Pendidikan khususnya di bidang

Kesehatan dan literasi di dalam memberikan pelayanan Kesehatan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinannya.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi keluarga, tenaga Kesehatan dan masyarakat terutama yang memiliki anggota keluarga dalam masa kehamilan yang mendekati pada persalinan agar tidak mengalami kecemasan dalam menghadapinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah mengikuti pembahasan dalam buku ini. Semoga informasi dan wawasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Anda dan keluarga.

Daftar Pustaka

- Az-Zahrani, Musfir bin Said. 2005. *Konseling Terapi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cahaya Saputri, L., & Sujarwo, S. (2017). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Menjelang Kelahiran Anak Pertama Pada Trimestre Ketiga. *Jurnal Ilmiah Psyche*, 11(2), 87–96.
- Cutler, H. C. (2004). *Seni Hidup Bahagia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Dinopawe, A., Makatita, B., & Alerbitu, K. L. (2021). Pengaruh Motivasi Suami dan Paritas terhadap kecemasan Ibu Hamil menjelang Persalinan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 10(1), 21–27.
- Elvina, L., & Rosdiana, E. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Kesiapan Psikologis Ibu Hamil Trimester III dalam Menghadapi Persalinan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 4(2), 176.
- Fauziah, F., Widuri, J. (2007). *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Kartini, Kartono. 2006 *Peran Keluarga Memandu anak*. Jakarta Rajawali. Cet II.
- Kholil Lur Rochman. (2010). *Kesehatan Mental*. Purwokerto: Fajar Media Press.
- Nevid, Jeffrey S., Spencer. A. Rathus, dan Greene, Beverly. 2005. *Psikologi abnormal*. (Terjemahan Tim Psikologi Universitas Indonesia). Edisi Kelima. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nugroho, Taufan, dkk. 2014. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan 3 Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika

- Oktavia, L. D. (2018). Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Pada Kehamilan. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang*, 2(6), 63–68.
- Ramaiah, S. 2003. *Kecemasan, Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. Jakarta. Penerbit: Pustaka Populer Obor.
- Ratnawati, A. (2020). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
- Retnaningtyas, E. (2016) Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–215.
- Robin, Gede. Hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas tidur pada ibu hamil primigravida trimester iii di Puskesmas Sidorejo Lampung Timur, SK (Penelitian) Skripsi, Universitas Malahayati, 2015; Available: <https://www.slideshare.net/gederobin/hubungan-tingkat-kecemasandengan-kualitas-tidur-ibu-hamil-primigravida-trimester-iii-51313032> (17 Juni 2021)
- Rohani. (2013). *asuhan kebidanan pada masa persalinan* . Jakarta: Salemba Medika.
- Rufaidah, Elina Rharisti.2009. Efektifitas Terapi Kognitif terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Penderita Asma di Surakarta. Tesis. Fakultas Psikologi-UGM.
- Rustikayanti R.N., I.Kartika dan Y.Herawati. 2016. Perubahan Psikologis Pada Ibu Hamil Trimester III. *The Southeast Asean Journal Of Midwifery*. Vol. 2, No.1 Hal: 45-49. Diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 12:10 WIB. Tersedia pada: aipkind.or.id/index.php/seajom/article/view/66
- Semiun, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 1*. Yogyakarta: Kanisinus
- Sondakh. 2013. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Erlangga.
- Sondakh Jenny J.S. 2015. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Erlangga

- Sumarah. (2012). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sulidah, Yamin, A., Susanti, R. D. (2016). Pengaruh Latihan Relaksasi Otot Progesif Terhadap Kualitas Tidur Lansia.E-Journal Keperawatan Vol. 4. No. 1.
- Suliswati dkk. (2005). Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: EGC
- Sulistyawati, A. (2013). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin. Jakarta: Salemba Medika.
- Sutardjo Wiramihardja. (2005). Pengantar Psikologi Abnormal. Bandung: Refika Aditama.
- Yulaikhah, L. (2019). Buku Ajaran Asuhan Kebidanan Kehamilan. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53).
- Zuhrotunida, & Yudiharto, A. (2017). Hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan di Puskesmas Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2016. Jurnal JKFT: Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2, 60-70.

Glosarium

A

Absorpsi: Proses Penyerapan di dalam tubuh

Amenorrhoe: tidak dapat haid

B

BAB: Buang Air Besar

BAK: Buang Air Kecil

Balotemen: tanda adanya janin dalam rahim yang ditandai dengan sensasi pantulan atau melenting ketika rahim diraba

Braxton Hicks: His palsu

C

Chadwick: Selama kehamilan mukosa vagina tampak gelap kebiruan atau merah keunguan, keadaan

Chloasma gravidarum: Setelah 16 minggu kehamilan, kulit di wajah menjadi gelap karena pengaruh sinar matahari.

F

FSH: Follicle Stimulating Hormon

G

Gastrointestinal: kondisi yang berkaitan dengan sistem pencernaan atau saluran gastrointestinal

Goodell: pelunakan serviks yang merupakan salah satu tanda kehamilan

H

HCG: human chorionic gonadotropin

Hegar: tanda kehamilan yang menandakan pelunakan jaringan serviks, terutama pada isthmus serviks, yaitu bagian serviks yang menghubungkan vagina dengan rahim

Hemoglobin: protein yang terdapat dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh

Hiperpigmentasi: kondisi kulit yang berubah warna menjadi lebih gelap dari area sekitarnya

HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir

HPL: Human placental lactogen

I

IM: Intramuskular

L

Leukorea: Keputihan

LH: Luteinizing Hormon

Linea nigra: Warna puting susu dan linea alba menjadi gelap akibat stimulasi melanofor akibat peningkatan hormon perangsang melanosit

M

Multigravida: istilah untuk wanita yang telah hamil dua kali atau lebih

S

Spider telangiectasis: Kelainan kulit yang disebabkan oleh tingginya kadar estrogen yang bersirkulasi, yang juga dapat terjadi pada gagal hati

Striae gravidarum: Benjolan di dada dan perut akibat rusaknya jaringan kolagen yang terlihat sebagai jaringan parut yang tidak beraturan. Hal ini diyakini disebabkan oleh aksi hormon aDrenokortikosteroid dan terjadi pada tahap akhir kehamilan

STH: Hormon somatotropin (STH) atau hormon pertumbuhan

U

Uterus (Rahim): organ berotot dan berongga yang berbentuk seperti buah pir terbalik dan terletak di panggul wanita

P

PAP: Pintu Atas Panggul

Palpasi Abdominal: prosedur medis yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi organ-organ dalam perut dengan cara menekan perut menggunakan tangan.

Partograf: merupakan alat bantu yang digunakan untuk memantau kemajuan kala I persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik

Pre eklamsia dan Eklampsia: kondisi gangguan tekanan darah tinggi yang berkaitan dengan kehamilan

Primigravida: seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya

Q

Quickening: Ketika wanita hamil merasakan isyarat gerakan janin pertama kali

Profil Penulis



Bdn. Warda Anil Masyayih, S.ST., M.Kes., Penulis dilahirkan di Kabupaten Banyuwangi, 17 Juni 1989. Penulis adalah seorang Dosen di salah satu institusi Kesehatan swasta di Jombang. Menyelesaikan pendidikan D-III pada Jurusan Kebidanan Stikes Husada Jombang dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Stikes Husada

Jombang serta melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Selama menempuh pendidikan S2 penulis dipercaya untuk menjadi Asisten Dosen di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang. Pernah Menjadi Dosen Kebidanan di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang – Malang, dan sekarang menjadi dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Penulis aktif dalam berorganisasi profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia). Penulis dapat dihubungi melalui email: wardaanil234@gmail.com atau nomor telepon 082331263065.

Profil Penulis



Bdn. Eny Siswati SST., M.Si, Lahir di Jombang, 18 Agustus 1979. Pertama kali menempuh Pendidikan Kesehatan di sekolah perawat Kesehatan Tahun 1998, Melanjutkan studi D4 kebidanan di Stikes Husada Jombang, Kemudian melanjutkan Studi Megister Sains Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian di tahun 2021 melanjutkan sekolah Bidan Profesi di Stikes Husada jombang. Perjalanan karir dimulai

dengan bekerja di pelayaran Kesehatan, di mana saya memperoleh pengalaman berharga dalam dunia kesehatan. Penulis memutuskan untuk melanjutkan karir di bidang pendidikan, khususnya di bidang kebidanan untuk mejadi Dosen, di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang. Untuk saat ini Penulis sebagai dosen tetap di STIKES Husada Jombang. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti Organisasi IBI dan menjadi Sekretasi IBI Ranting Sngosari. Penulis dapat dihubungi melalui email: enyiswanti18@gmail.com atau nomor telepon 082142614182.

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang pentingnya dukungan keluarga pada masa kehamilan agar mengurangi kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Kecemasan saat hamil umumnya disebabkan oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh. Perubahan kadar hormon saat hamil bisa berpengaruh pada kadar zat kimia di otak yang berperan pada pengaturan perasaan. Inilah sebabnya mengapa ibu hamil cenderung mudah cemas, gelisah, dan khawatir. Ketakutan dan kecemasan dalam masa kehamilan dapat menyebabkan masalah seperti persalinan premature dan berat badan lahir rendah.

Buku ini ditulis agar pembaca dapat memahami bagaimana agar kecemasan pada ibu hamil dapat dicegah sehingga ibu hamil dalam menghadapi persalinannya dengan keadaan Bahagia.

Adapun cara yang dapat dilakukan suami dan keluarga dalam memberikan dukungan pada ibu hamil antara lain: Turut serta membantu dalam mengurus urusan rumah tangga. Berada dekat dengan ibu hamil untuk mendengarkan keluhan serta memberikan semangat pada ibu hamil. Memonitor asupan gizi pada masa kehamilan

Buku ini dapat memberikan wawasan kepada individu pembaca dan juga dapat memberikan wawasan pada tenaga profesional Kesehatan beserta organisasi Kesehatan dalam mendapatkan referensi agar dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan pada ibu hamil dan bersalin.

Buku ini membahas tentang pentingnya dukungan keluarga pada masa kehamilan agar mengurangi kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Kecemasan saat hamil umumnya disebabkan oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh.

Perubahan kadar hormon saat hamil bisa berpengaruh pada kadar zat kimia di otak yang berperan pada pengaturan perasaan. Inilah sebabnya mengapa ibu hamil cenderung mudah cemas, gelisah, dan khawatir. Ketakutan dan kecemasan dalam masa kehamilan dapat menyebabkan masalah seperti persalinan premature dan berat badan lahir rendah.

Buku ini ditulis agar pembaca dapat memahami bagaimana agar kecemasan pada ibu hamil dapat dicegah sehingga ibu hamil dalam menghadapi persalinannya dengan keadaan Bahagia.

Adapun cara yang dapat dilakukan suami dan keluarga dalam memberikan dukungan pada ibu hamil antara lain: Turut serta membantu dalam mengurus urusan rumah tangga. Berada dekat dengan ibu hamil untuk mendengarkan keluhan kesah serta memberikan semangat pada ibu hamil. Memonitor asupan gizi pada masa kehamilan. Buku ini dapat memberikan wawasan kepada individu pembaca dan juga dapat memberikan wawasan pada tenaga profesional.

Kesehatan beserta organisasi Kesehatan dalam mendapatkan referensi agar dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan pada ibu hamil dan bersalin.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

